ALL. A1

Per struttura non residenziale semplici monopresidio

(vedi definizioni art. 2 e classificazione art. 3 del D.A. 9 gennaio 2024 n. 20).

Per una puntuale applicazione di ciascun requisito fare riferimento ai subcodici riportati nell'allegato A1 del D.A. 9 gennaio 2024 n. 20.

Il Responsabile della struttura mettera a disposizione del GdV prima della visita i seguenti

DOCUMENTO	Cod. Requisito
1. Documento che definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse	*1A.01.03.01*
2. Documentazione inerente il sistema informativo	*1A.01.04.01*
3. Documento/programma che descrive le modalita per la valutazione e il miglioramento della qualita dell...	*1A.01.05.01*
4. Procedura per la presentazione e gestione di reclami, osservazioni e suggerimenti.	*1A.01.06.01*
5. Documento/procedura che descrive le modalita di erogazione dell'assistenza	*1A.02.02.01*
6. Piano per la gestione delle emergenze	*1A.02.02.02*
7. Protocollo per l'isolamento di pazienti con patologie contagiose o potenzialmente tali	*1A.02.02.03*
8. Procedura che definisce i requisiti per la redazione, l'aggiornamento, la conservazione e la verifica dell...	*1A.02.05.01*
9. Documento formale di incarico del responsabile della Manutenzione	*1A.03.01.01*
10. Inventario delle attrezzature aggiornato e verificato annualmente e procedura per l'identificazione dell...	*1A.03.02.01*
11. Piano per la gestione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle strutture, impianti, attrezzatur...	*1A.03.02.02*
12. Documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature e apparecchiature immediatamente disponi...	*1A.03.02.03*
13. Documentazione tecnica - caratteristiche ambientali e accessibilita	*1A.03.05.01*
14. Documentazione tecnica - protezione antincendio	*1A.03.05.02*
15. Documentazione tecnica - protezione acustica	*1A.03.05.03*
16. Documentazione tecnica - sicurezza elettrica e continuita elettrica	*1A.03.05.04*
17. Documentazione tecnica - sicurezza anti-infortunistica	*1A.03.05.05*
18. Documentazione tecnica - protezione da radiazioni ionizzanti	*1A.03.05.06*
19. Documentazione tecnica - eliminazione barriere architettoniche	*1A.03.05.07*
20. Documentazione tecnica - smaltimento dei rifiuti	*1A.03.05.08*
21. Documentazione tecnica - condizioni microclimatiche	*1A.03.05.09*
22. Documentazione tecnica - impianti di distribuzione dei gas	*1A.03.05.10*
23. Documentazione tecnica - materiali esplodenti	*1A.03.05.11*
24. Documentazione tecnica - protezione antisismica	*1A.03.05.12*
25. Obblighi assicurativi definiti dalla normativa applicabile	*1A.04.12.04*
26. Carta dei servizi	*1A.05.03.01*
27. Modalita identificazione di tirocinanti, specializzandi e altri soggetti che intervengono nel percorso assi...	*1A.05.03.03*
28. Report criticita riscontrate dall'analisi dei reclami e dei risultati delle indagini di customer satisfaction e...	*1A.05.03.05*
29. Piano aziendale per la gestione del rischio	*1A.06.02.01*
30. Procedura per la pulizia e sanificazione degli ambienti	*1A.06.02.02*
31. Procedura per la protezione dagli incidenti per esposizione a materiale biologico o altre sostanze peri...	*1A.06.02.03*
32. Sistema (Piani di intervento/report) per l'identificazione e la segnalazione di near miss, eventi avversi ...	*1A.06.02.04*

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 1:

Documento che definisce ed esplicita l'organizzazione e le politiche di gestione delle risorse

Cod. Requisito
1A.01.03.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 1

Cod. Requisito 1A.01.03.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Il presente documento descritto è un Piano di Organizzazione e Gestione delle Risorse (POG-R) o un Piano di Gestione dei Servizi, che definisce le politiche, i processi e la struttura organizzativa per l'uso efficiente delle risorse e include un'analisi dei processi per identificare i punti deboli e i possibili disservizi dello studio Odontoiatrico.
L'obiettivo è garantire un'organizzazione ottimale e prevenire problemi operativi, spesso attraverso l'analisi dei rischi e l'implementazione di procedure di controllo interno.
Funzioni e scopi del documento

- **Definizione dell'organizzazione:**

Descrive la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità per la gestione delle risorse.

- **Politiche di gestione:**

Stabilisce le regole e i principi che guidano l'uso delle risorse, come finanziarie, umane e materiali.

- **Analisi dei processi:**

Mappa i processi aziendali per identificare le fasi critiche in cui potrebbero verificarsi disservizi, errori o inefficienze.

- **Prevenzione dei disservizi:**

Individua le criticità e implementa azioni correttive o preventive per mitigare i rischi e garantire la continuità dei servizi.

- **Controllo interno:**

Supporta l'implementazione di un sistema di controllo interno per assicurare la conformità alle procedure e la salvaguardia delle risorse.

- **Base documentale:**

Fornisce una base documentale che può essere utilizzata per la formazione, la revisione e il miglioramento continuo delle operazioni.

Contenuti tipici

- **Mappatura dei processi:**

Descrizione dettagliata delle attività e delle interazioni tra le diverse unità organizzative.

- **Analisi dei rischi:**

Identificazione dei rischi associati a ogni fase del processo e valutazione della loro probabilità e impatto.

- **Piani di mitigazione:**

Descrizione delle misure preventive e correttive da attuare per ridurre i rischi.

- **Indicatori di performance:**

Definizioni degli indicatori chiave di performance per monitorare l'efficienza e l'efficacia dei processi.

- **Procedure operative standard:**

Istruzioni dettagliate su come svolgere le attività operative.

Documento Organizzativo e di Gestione delle Risorse
Studio Odontoiatrico DOTT.SSA BARBARA SABIU

1. Scopo del Documento

Il presente documento ha l’obiettivo di definire e rendere esplicita l’organizzazione interna dello studio odontoiatrico e le politiche adottate per la gestione delle risorse (umane, materiali e tecnologiche). Inoltre, analizza i principali processi operativi per individuare eventuali fasi critiche in cui possono verificarsi disservizi, al fine di prevenirli e garantire un servizio di qualità e in sicurezza per i pazienti.

2. Struttura Organizzativa dello Studio

2.1 Personale e Ruoli

- Responsabile Sanitario / Titolare: Coordinamento generale, supervisione clinica e gestionale.

■ Odontoiatri collaboratori: Esecuzione dei trattamenti e presa in carico dei pazienti.
■ Igienisti dentali: Prevenzione, educazione e igiene orale.
■ Assistenti alla poltrona (ASO): Supporto clinico e logistico alle attività odontoiatriche.
■ Personale amministrativo: Accoglienza, gestione appuntamenti, documentazione, fatturazione.

2.2 Comunicazione Interna

■ Riunioni periodiche di coordinamento (mensili o bimestrali).
■ Uso di software gestionale per la condivisione di informazioni cliniche e organizzative.
■ Canali interni di comunicazione digitale (email, chat interne, agenda condivisa).

3. Politiche di Gestione delle Risorse

3.1 Risorse Umane

■ Aggiornamento continuo e formazione obbligatoria (corsi ECM, formazione ASO).
■ Affiancamento e formazione on-the-job per nuovo personale.
■ Verifica annuale delle competenze e colloqui di feedback.

3.2 Risorse Materiali e Tecnologiche

■ Manutenzione periodica delle attrezzature odontoiatriche secondo calendario prestabilito.
■ Controllo di scorte e materiali sanitari (sistemi di inventario automatico o manuale).
■ Adozione di software gestionali aggiornati per appuntamenti, cartelle cliniche e amministrazione.

3.3 Sicurezza e Igiene

■ Adozione dei protocolli di sterilizzazione e sanificazione secondo normative vigenti.
■ Formazione del personale in materia di sicurezza sul lavoro e gestione emergenze.

Verifica periodica del rispetto delle normative igienico-sanitarie.

4. Analisi dei Processi e delle Fasi Critiche

L’analisi dei principali processi permette di individuare punti di rischio e prevenire i disservizi. Di **seguito una tabella riepilogativa:**

Azioni Preventive /
Processo Fase Critica Possibili Disservizi
Correttive
Software gestionale,
Accoglienza del Errori agenda, attese promemoria
Prenotazione, accettazione
paziente prolungate automatici, conferma
telefonica

Errori clinici, Check-list, formazione
Trattamento clinico Diagnosi, esecuzione terapia strumentazione non continua, protocolli
disponibile clinici

Manutenzione
Sterilizzazione Pulizia, imbustamento, Contaminazione,
periodica, tracciabilità
strumenti gestione autoclave malfunzionamento
sterilizzazione

Backup, digitalizzazione
Gestione Errori documentali,
Fatturazione, archiviazione documenti, formazione
amministrativa perdita dati
amministrativi

Mancanza di
Promemoria
Comunicazione con Informazioni pre/post informazioni,
SMS/email, materiale
pazienti trattamento, follow-up appuntamenti
informativo standard
dimenticati

5. Monitoraggio e Miglioramento Continuo

Lo studio si impegna in un processo continuo di miglioramento della qualità attraverso:

- Raccolta del feedback da parte dei pazienti (questionari cartacei o digitali).
- Audit interni periodici per la verifica del rispetto delle procedure.
- Revisione degli eventi critici, analisi delle cause e implementazione di azioni correttive.
- Aggiornamento dei protocolli interni in base alle normative vigenti e ai risultati delle verifiche.

6. Conclusioni

Una gestione strutturata ed efficiente delle risorse è essenziale per garantire l'eccellenza del servizio odontoiatrico offerto ai pazienti. Questo documento rappresenta una guida pratica per il personale, promuovendo la qualità, la sicurezza e il miglioramento continuo in ogni area dello studio.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 2:

Documentazione inerente il sistema informativo

Cod. Requisito
1A.01.04.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 2

Cod. Requisito 1A.01.04.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Premessa
Il Codice sulla privacy impone a chiunque tratta informazioni relative ad altre persone, imprese, enti od associazioni di rispettare alcuni principi fondamentali a garanzia della riservatezza dei dati stessi.
Il Codice prescrive precisi obblighi e comportamenti da attuare nel trattare i dati; questi obblighi sono sanzionati anche penalmente: è necessario, pertanto, procedere all'adeguamento dell'organizzazione dello studio Studio Sabiu SRL al fine di rispettare gli obblighi imposti dal Codice.
Con il presente documento si definisce, ai sensi delle disposizioni di legge, le procedure che definiscono le modalità con cui è garantita la integrità dei dati adottate dallo Studio odontoiatrico del Dott.ssa Barbara Sabiu sito in San Giovanni Suergiu Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU).
Il documento procede, innanzi tutto, all'Identificazione delle Risorse da proteggere, risorse che in diverso modo operano o comunque svolgono un ruolo significativo nei processi di trattamento dei dati personali, si passa poi all'analisi ed all'elenco dei trattamenti e quindi alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito della struttura organizzativa. Poi, tramite l'Analisi dei Rischi, sono state analizzate le minacce e le vulnerabilità a cui le risorse sono sottoposte, in modo da potere valutare gli elementi che possono insidiare la protezione, l'integrità e la conservazione di ogni singolo dato personale trattato.
Valutati i rischi, si è redatto un Piano di Sicurezza tramite il quale si è provveduto a definire l'insieme delle misure fisiche, logiche ed organizzative adottate per tutelare le strutture e le risorse preposte al trattamento dei dati e le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.
Inoltre, è stato definito un Piano di Verifiche delle misure adottate tramite il quale si provvederà ad accertare, periodicamente, la bontà delle misure individuate e ad apportare gli accorgimenti che si riveleranno necessari ed opportuni.
Parallelamente alla stesura del Piano di Verifiche è stato redatto un Piano di Formazione degli Incaricati tramite il quale si renderanno edotti gli incaricati del trattamento dei rischi e dei modi per prevenire i danni.
Il documento, inoltre, fornisce idonee informazioni relative alla tipologia di dati sensibili trattati e all'analisi dei rischi connessi all'utilizzo degli strumenti mediante i quali viene effettuato il trattamento.

Il Documento si applica al trattamento di tutti i dati personali per mezzo di:

- Strumenti elettronici di elaborazione
- Altri strumenti di elaborazione (es. cartacei, audio, visivi e audiovisivi, ecc.)

Il Documento deve essere conosciuto ed applicato da tutti i componenti e collaboratori dello studio

Risorse Hardware
Le risorse hardware utilizzate per trattare i dati personali sono analizzate nelle seguenti schede **riepilogative:**

SCHEDA RILEVAZIONE RISORSE HARDWAREN.01

Codice: PC01
Modello: HP OMEN 15

Sistema Operativo: Windows11
Categoria: [] Sistema Elaborativo Server
[] Sistema Elaborativo Client
[x] Altro Sistema: PC stand alone
Elaboratore in rete: [] No
[X] Rete Privata
[ ] Rete Disponibile al pubblico:

Dislocazione: Segreteria/ sala operativa 1
Operatore: Dott.ssa Barbara Sabiu

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Presenza di Password: []No
[x]Si
Note: L'utente può cambiare autonomamente la password
Antivirus: [ ] No

[x] Si
Tipo/Prodotto: kaspersky internet
security

Periodicità: aggiornamento:

Automatico
Firewall: [ ] No
[x] Si
Tipo/Prodotto: Presente nel
Sistema Operativo

Note:

Gruppo di Continuità: [ ] No
[x]Si

COMPONENTI DI RILIEVO AI FINI DELLA SICUREZZA DEI

DATI

Componente Descrizione
Supporti di memorizzazione HD locale da 1TB
Masterizzatore DVD
Dual.Rom
PenDrive Flash Disk
Cloud. NO
Connessione Internet Si

Banche dati

Gli archivi e le banche dati contenenti i dati personali trattati sono i seguenti:

- **BANCA DATI CLIENTI;**
- **BANCA DATI FORNITORI;**

Pag. 2di8

- **BANCA DATI DIPENDENTI**

SCHEDA RILEVAZIONE BANCHE DATIN. 01

Codice: BD01
Descrizione: BANCA DATI CLIENTI: In questa
banca dati sono conservati i dati dei
clienti.
Tipologia risorsa: [x]Archivio Elettronico
[x] Archivio Cartaceo

Nota:

Ubicazione Cartacea: in Segreteria
Banca Dati Elettronica: Segreteria
Incaricati della Raccolta Dot. Dott.ssa Barbara Sabiu
Metodologia di Archiviazione
Elettronica: Applicativo Software

Risorse Hardware su cui è allocata: PC01

STRUMENTI E POLITICHE DI BACKUP

Dispositivo di backup: [] Non esistente
[x] Si, presente

Note:

Frequenza di backup: [] Giornaliera
[X]Settimanale
[ ] Periodico
Incaricati del backup: Dot. Dott.ssa Barbara Sabiu
Modalità Operative: Mensilmente viene effettuato un
backup completo.
Supporti di backup: Pendrive
Etichettatura: Denominazione univoca cartella di
destinazione
Luogo di conservazione: Studio
Verifica backup: La verifica del backup è effettuata
confrontandole dimensioni dei file

di backup con le dimensioni dei file
originali.

Pag. 3di8

Analisi dei Rischi sulle Aree e sui Locali

Risorsa Elemento di Rischio Soglia Motivazione
Individuata
Tutte Accesso nei locali dove si svolge Bassa L'accesso allo studio è sempre controllato
il trattamento (rapine, furti, atti durante il normale svolgimento
vandalici) dell'attività lavorativa.
Tutte Allagamenti Bassa Area non soggetta ad inondazioni o calamità
di questo tipo.
Tutte Incendio Bassa La sede è provvista di dispositivi
antincendio.
Tutte Cortocircuito Bassa La sede è provvista di impianti a norma.

Pag. 4di8

Analisi dei Rischi sulle Risorse Hardware

Risorsa Elemento di Soglia Motivazione
Rischio Individuata

Tutte Uso non autorizzato Bassa L'utilizzo dell'hardware è soggetto all'utilizzo di
dell'hardware credenziali d'accesso.

Tutte Manomissione/Sabot Bassa Alle risorse non accedono persone non autorizzate.
aggio La manutenzione è effettuata da tecnici autorizzati.

Tutte Probabilità/Frequenz Bassa L'hardware acquistato è di qualità e non ha
a di guasto mai dato problemi rilevanti.

Tutte Rischi connessi Bassa Gli elaboratori sono dotati di gruppo di continuità
all'elettricità che fornisce energia di buona qualità
(stabilizzazione) e impedisce
l'improvvisa assenza di corrente elettrica.

Tutte Rischi connessi alla Bassa Sono previste procedure di backup settimanali su
l'integrità e la supporti informatici e Hard-disk. Tutti i sistemi
sicurezza dei dati informatici sono dotati di antivirus aggiornati e la
scansione degli hard disk viene effettuata
settimanalmente.
La gestione dei dati informatici è soggetta ad
accesso protetto da password con credenziali
gestite dal Titolare dello studio odontoiatrico.
Per i dati in formato cartaceo è prevista la loro
digitalizzazione con conseguente trattamento come
dati informatici o in alternativa produzione di copie
fotostatiche da conservare in archivio separato.

Pag. 5di8

Analisi dei Rischi sulle Banche Dati

Risorsa Elemento di Rischio Soglia Motivazione
Individuata
Tutte Accesso non autorizzato Bassa L'accesso alle risorse dati
informato elettronico avviene
solo tramite gli elaboratori
protetti dall'utilizzo di
credenziali d'accesso gestite
dal titolare
Tutte Intrusione da parte di soggetti Bassa Le risorse sono protette da
Estranei o non autorizzati al Un idoneo firewall software.
trattamento dei dati
Tutte Cancellazione non autorizzata di Bassa L'accesso alle risorse dati in
dati/Manomissione di dati formato elettronico avviene
solo tramite gli elaboratori
protetti dall'utilizzo di
credenziali d'accesso gestite
dal titolare e solo i diretti
incaricati.

Tutte Perdita di dati Bassa Vengono effettuate copie
periodiche di backup delle
banche dati. I PC sono
dotati di Software Anti virus
costantemente aggiornato.

Misure di Sicurezza adottate

Descrizione Misura Criteri per la corretta applicazione
Custodia dei supporti I supporti che vengono utilizzati per l'attività di backup sono conservati in
un cassetto/armadio con serratura custodite dal titolare
Integrità e la sicurezza dei dati Sono previste procedure di backup settimanali su supporti informatici e su
Hard-disk. Tutti i sistemi informati ci sono dotati di antivirus aggiornati e
la scansione deglihard diskviene effettuata settimanalmente. Per i dati in
formato cartaceo è prevista la loro digitalizzazione con conseguente
trattamento o in alternativa produzione di copie fotostatiche da conservare
in archivio separato.

Continuità dell'alimentazione elettrica Gli HD e le Pendrive dedicate ove sono contenute le banche dati sono
collegati ad un gruppo di continuità che garantisce una stabilizzazione
dell'energia elettrica erogata. Il gruppo garantisce inoltre una autonomia
temporale di esercizio sufficiente a chiudere correttamente tutte le
applicazioni e completare la procedura di spegnimento dell'elaboratore.
Verifica dell'esito del backup Sistematicamente dopo aver fatto la copia di backup settimanale,
l'incaricato ne testa il contenuto dei dati registrati verificando nel contesto
l'integrità.
Dispositivi antincendio I locali sono dotati di estintori regolarmente mantenuti.

Pag. 6di8

Raccolta, archiviazione e custodia di atti, documenti e supporti.
La politica di gestione dei dati sensibili dei pazienti ad oggi i è esclusivamente in formatto cartaceo.
Il PC è impiegato esclusivamente per la gestione del database degli apparecchi radiografici digitali, e
successivamente sarà implementato un sistema informatico per la gestione delle cartelle cliniche.
Per quanto concerne la raccolta, la custodia e l'archiviazione di atti, documenti e supporti diversi si è
provveduto a dotare lo studio di cassetti con serratura ed armadi chiudibili a chiave nei quali si deporranno i
documenti sanitari cartacei contenenti dati sensibili.
Le chiavi sono in possesso del Dott.ssa Barbara Sabiu in qualità di Titolare dello studio odontoiatrico.
Ad oggi non è presente personale dipendente né sono presenti collaboratori odontoiatri.
Nella futura eventualità di personale dipendente verranno date loro disposizioni, per iscritto, di accedere ai
soli dati personali, la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati, e
nello specifico sarà loro prescritto di prelevare dagli archivi informatici i soli atti e documenti che vengono
loro affidati per lo svolgimento delle mansioni lavorative, che devono controllare e custodire, durante l'intero
ciclo necessario per lo svolgimento delle operazioni di trattamento, per poi restituirli all'archivio, al termine
di tale.
Per quanto concerne l'archiviazione elettronica dei dati sensibili dei pazienti, il Dott.ssa Barbara Sabiu in
qualità di Titolare dello studio odontoiatrico ha predisposto il software con livello di protezione agli accessi
garantito da password di accesso modificabili esclusivamente dal Titolare.
Gli impianti e le attrezzature, per la custodia e l'archiviazione di atti, documenti e supporti, con particolare
riferimento a quelli contenenti dati sensibili, di cui è dotato lo studio appaiono soddisfacenti, al fine di
garantire la necessaria sicurezza ai dati personali contenuti in tali atti, documenti e supporti.

Criteri e modalità di ripristino dei dati
Per fronteggiare le ipotesi in cui i dati siano colpiti da eventi che possano danneggiarli, o addirittura
distruggerli, vengono previsti criteri e modalità tali, da garantire il loro ripristino in termini ragionevoli, e
comunque entro una settimana per i dati sensibili.
I documenti cartacei, e gli eventuali supporti diversi da quelli elettronici, contenenti dati personali, vengono
fotocopiati.
I supporti contenenti le copie vengono archiviati in armadi chiusi a chiave.
Per i dati trattati con strumenti elettronici, sono previste procedure di backup, attraverso le quali viene
periodicamente effettuata una copia di tutti i dati presenti nel sistema, su dispositivi opportuni.

Il salvataggio dei dati trattati avviene come segue:

■ la frequenza è settimanale;
■ si utilizzano supporti differenti da quelli in cui sono contenuti i dati dei salvataggi eseguiti la volta
precedente;
■ per ciascun salvataggio, si esegue 1copia.

Piano di Verifica delle Misure adottate
Al Dott.ssa Barbara Sabiu è affidato il compito di aggiornare le misure di sicurezza, al fine di adottare
gli strumenti e le conoscenze, resi disponibili dal progresso tecnico, che consentano di ridurre al minimo
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato odi trattamento

non consentito.
Al fine di verificare l'efficacia delle misure di sicurezza adottate, il Titolare provvede con frequenza

mensile, anche con controlli a campione, ad effettuare una o più delle seguenti attività:

- verificare l'accesso fisico ai locali dove si svolge il trattamento;
- verificare la correttezza delle procedure di archiviazione e custodia di atti, documenti e supporti contenenti dati personali;
- verificare l'integrità dei dati e delle loro copie di backup;
- verificare la sicurezza delle trasmissioni in rete;
- verificare che i supporti magnetici, che non possono più essere riutilizzati, vengano di strutti.

Almeno ogni sei mesi, si procederà ad una sistematica verifica del corretto utilizzo delle parole chiave e dei profili di autorizzazione che consentono l'accesso agli strumenti elettronici.
Pag. 7di8

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 3:

Documento/programma che descrive le modalita per la valutazione e il miglioramento della qualita delle prestazioni e dei servizi erogati

Cod. Requisito
1A.01.05.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 3

Cod. Requisito 1A.01.05.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Il presente documento definisce i criteri e le modalità operative applicate dallo Studio Odontoiatrico nel pianificare, programmare e gestire le modalità per la valutazione e ilmiglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi erogati, le attività di valutazione e miglioramento del sistema di gestione per la qualità, ma anche e soprattutto per migliorare continuamente l'efficacia del sistema stesso.

Quanto descritto in questo documento, infatti, è fondamentale per una organizzazione che:

■ Ha l'esigenza di dimostrare la propria capacità di fornire prestazioni che ottemperino alle necessità dei pazienti;
■ Considera l'accrescimento della soddisfazione del paziente un obbiettivo fondamentale che porta inevitabilmente ad una continua ricerca del miglioramento dell'efficacia del proprio sistema di gestione.
Lo Studio intende gestire il miglioramento continuo del proprio sistema di gestione per la

qualità, con riferimento a:

■ Soddisfazione del paziente, come metodo efficace di rilevazione dell'efficacia del sistema di gestione;
■ Verifiche interne, come metodo di rilevamento finalizzato a verificare che l'applicazione del sistema rispetti quanto pianificato, e che sia efficacemente attuato e costantemente aggiornato.
Lo Studio Odontoiatricomisura e analizza costantemente la soddisfazione dei pazienti al fine di valutare se siano stati soddisfatti i requisiti da lui richiesti, essendo questo uno dei maggiori rilevatori dell'efficacia della gestione del sistema per la qualità.

Lefontidiinformazionisullasoddisfazionedelpazientesono:

■ Incontriconipazienti;
■ I questionarisoddisfazione;
■ Controllo delle non conformità rilevate in tutte le fasi di erogazione dei servizi e delle prestazioni;
■ Gestione dei reclami provenienti dai pazienti relativamente alle prestazioni e ai serviziforniti al fine di migliorare il servizio offerto ed erogato;

■ Incrementodelnumerodeipazienti.
I reclamie le comunicazioni dirette, e la loro registrazione, forniscono un'evidenza continua dello stato di soddisfazione o insoddisfazione dei pazienti e sono costantemente monitoratedallo Studio Odontoiatrico.
L'analisi delle risposte al questionario indica il grado di soddisfazione/insoddisfazione in fase di

Pag.2di4

erogazione del servizio e delle prestazioni.

Le Verifiche Interne sono uno strumento di particolare efficacia per mantenere un adeguato controllo sullo stato del Sistema Qualità adottato e vengono svolte in conformità ad un programma interno delle verifiche".
Nello Studio le verifiche vengono svolte con spirito costruttivo allo scopo di evidenziare ed eliminare le carenze, nonché di sensibilizzare il personale interessato alle proprie responsabilità.

A tale scopo:

a) Il programmadelle verifichevienepredispostodaltitolare.
La frequenza delle Verifiche varia in relazione alla criticità dei processi da verificare e/o sulla base dei riscontri delle Verifiche precedenti.
b) Le Verifiche vengono generalmente svolte dal Titolare dello Studio, che può avvalersi della collaborazione di personale competente esterno o interno, nel settore da verificare, purché non direttamente responsabile dell'aspetto da verificare.

Procedura:

b) Raccolta ed archiviazione tutta la documentazione oggetto della Verifica a seguito di rilevamento di carenzeriscontrate su riscontro della clientela in merito ad organizzazione, efficienza ed appropriatezza dei servizi resi
c) Predispone l'analisi dei processi da verificare;
d) Comunica al Personale interessato la data e gli obiettivi della Verifica con almeno 3 giorni di preavviso;

e) Concorda con il Personale interessato un programma di risoluzione delle carenze (definendo aspetti, metodiche e tempi di risoluzione);
f) Verifica la risoluzione delle carenze riscontrate nei tempi previsti;
g) Trasmissione copia della documentazione al Titolare ed aggiornamento eventuale della carta dei servizi
Tuttiprocessidescrittivengonogestitiinotticadimiglioramentocontinuativo.
Il Titolare ha individuato nella gestione dei seguenti strumenti le opportunità di miglioramento

effettivo che possono essere individuati in:

- Riesame della direzione;
- Analisi dei risultati delle verifiche interne;
- Misurazioni dei processi/servizi e della soddisfazione dei pazienti;
- Rispetto della politica della qualità e degli obiettivi della qualità

Pag.3di4

determinati.

Le Azioni Correttive possono attivarsi per:

- Esitinegativi delle verifiche ispettive;
- Riesami del sistema qualità;
- ReclamideiPazienti;
- Osservazioni non conformità dell’ente di controllo.

Le Azioni Preventive vengono intraprese qualora, analizzando i vari dati disponibili presso l’Studio o provenienti dall’esterno, si individuino dalle situazioni a rischio che rendono

opportune delle attività di miglioramento o di prevenzione:

- Reclamideipazienti;
- Derogheoconcessioni;
- Propostedimiglioramentodelpersonale(suggerimenti).

Pag.4di4

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 4:

Procedura per la presentazione e gestione di reclami, osservazioni e suggerimenti.

Cod. Requisito
1A.01.06.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 4

Cod. Requisito 1A.01.06.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

La presentazione di un reclamo da parte di un cittadino che utilizzerà i servizi dello studio è un segnale sulla possibile esistenza nel sistema aziendale di disfunzioni che possono avere la loro causa nell'organizzazione, nella struttura tecnica dei servizi, nei comportamenti del Personale.

Ai fini del mantenimento dei più alti livelli di qualità del servizio, che costituisce l'obiettivo strategico dello Studio tale segnale è di importanza fondamentale perché consente di intervenire per l'eliminazione delle disfunzioni e di riportare ai livelli la qualità dei servizi.

Lo Studio si doterà di una procedura formalizzata per la trattazione dei reclami che mira non soltanto alla risoluzione del problema posto in evidenza ma anche ad agire come importante informazione di ritorno sull'efficacia ed efficienza del sistema qualità dell'azienda.

I cittadini utenti possono presentare eventuali reclami per disservizi subiti prima, durante e dopo l'esecuzione delle prestazioni erogate dal Centro; il reclamo può essere inoltrato con le seguenti **modalità:**

- per iscritto, utilizzando il modulo predisposto disponibile presso l'ufficio di accettazione;
- per iscritto su carta semplice o a mezzo mail;
- verbalmente rivolgendosi al Personale in servizio presso Lo Studio.

Il Dott. Francesco Teresi titolare dello Studio fornirà una risposta a tutti i reclami entro il termine massimo di 8giorni.

Si allega il modello che sarà utilizzato dello studio:

Gentile Signora/Gentile Signore
Il questionario a cui Lei, se vorrà, potrà rispondere è formulato in forma anonima con lo scopo di conoscere il grado di soddisfazione per le prestazioni e i servizi erogati da questo studio.
Le Sue risposte e gli eventuali suggerimenti serviranno a migliorare il livello delle prestazioni dei servizi. È sufficiente che sbarri con una croce la risposta che ritiene più giusta.

1. Come valuta l'ubicazione dell'ambulatorio per facilità di accesso, raggiungimento, e presenza di ostacoli?
Buona Sufficiente Insufficiente Scarsa

2. Come giudica il sistema di prenotazione?

Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

3. Come giudica il sistema di accoglienza?

Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

4. Come giudica il sistema di accettazione?

Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

5. Come giudica la prestazione sanitaria?

Buona Sufficiente Insufficiente Scarsa
6. Come valuta la disponibilità del front-office e l'atteggiamento mostrato nel venire in contro alle sue esigenze?
Buona Sufficiente Insufficiente Scarsa
7. Comevalutanelsuoinsiemetuttoilpercorsodallarichiestadelsuomedicoall'esecuzionedellaprestazione?
Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

Qualora avesse dei suggerimenti da proporre, La invitiamo a scriverle nello spazio sottostante.

Grazie per la collaborazione
LA DIREZIONE

P.S. Dopo aver debitamente compilato questo stampato, affinché il tutto avvenga in modo anonimo, La invitiamo a depositarlo presso la segreteria in apposito contenitore.

Lo studio Odontoiatrico è in fase di apertura, pertanto si prevede che a seguito della apertura può essere che sarà designato formalmente un referente per i rapporti con il pubblico individuabile con la **figura di:**

- Addetto alla Segreteria (attualmente non presente)

Sino ad allora l’incarico sarà coperto direttamente dal Titolare dello Studio.

Tutto il personale (eventuali dipendenti e/o collaboratori esterni) sarà formato ed informato sulla gestione dei reclami, osservazioni e/o suggerimenti. Le schede di valutazione da parte del pubblico saranno disponibili in sala di attesa e si predisporranno a campione delle interviste ai pazienti ed ai loro familiari.
Nello specifico si terrà una riunione interna per la presentazione del modello indicante la gestione di eventuali reclami, osservazioni e suggerimenti

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 5:

Documento/procedura che descrive le modalita di erogazione dell'assistenza

Cod. Requisito
1A.02.02.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 5

Cod. Requisito 1A.02.02.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

La presente procedura ha lo scopo di descrivere in modo chiaro e uniforme le modalità di erogazione dell'assistenza odontoiatrica presso lo Studio del Dott. Francesco Teresi, garantendo qualità, sicurezza del paziente e conformità alle normative vigenti (D.Lgs. 81/08, GDPR, normative sanitarie regionali, Linee guida Ministero della Salute).

1. Campo di applicazione

La procedura si applica a tutte le attività cliniche e assistenziali erogate all'interno dello studio **odontoiatrico, comprese:**

- Visite odontoiatriche e diagnostiche
- Trattamenti terapeutici e chirurgici
- Prestazioni igienico - preventive
- Gestione delle urgenze odontoiatriche

2. Riferimenti normativi

- D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Regolamento UE 2016/679 (GDPR) – Protezione dei dati personali
- Linee guida del Ministero della Salute per la sicurezza del paziente odontoiatrico
- Codice Deontologico degli Odontoiatri

3. Responsabilità

- Titolare: supervisione generale del processo assistenziale, esecuzione delle prestazioni cliniche, diagnosi, trattamento, consenso informato, gestione strumenti, disinfezione e sterilizzazione, gestione accettazione, anagrafica, appuntamenti, privacy.

4. Descrizione della procedura

4.1 Accoglienza e accettazione del paziente

1. Il paziente viene accolto dal titolare dello studio o da eventuale personale amministrativo,
2. Vengono registrati i dati anagrafici e acquisiti i consensi informati (privacy e trattamento sanitario).
3. Viene fissato o confermato l'appuntamento con l'odontoiatra.

4.2 Valutazione clinica e piano di trattamento

1. L'odontoiatra effettua l'anamnesi generale e odontoiatrica.

2. Si procede con l'esaminare il paziente.

3. Viene elaborato un piano di trattamento personalizzato, discusso e approvato dal paziente mediante consenso informato scritto.

4.3 Erogazione della prestazione odontoiatrica

1. Il titolare, verificando pulizia, sterilità e funzionamento delle attrezzature.
2. L'odontoiatra esegue la prestazione secondo protocolli clinici e linee guida.
3. Durante la seduta vengono rispettate le procedure di sicurezza e prevenzione del rischio biologico (uso DPI, gestione rifiuti sanitari, disinfezione).
4. Al termine, il titolare provvede alla detersione, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti utilizzati.

4.4 Follow-up e monitoraggio

1. Al termine della prestazione, vengono fornite al paziente le indicazioni post-operatorie o di mantenimento.
2. si pianifica eventuali controlli successivi.

3. Tutti i dati clinici vengono registrati nella cartella odontoiatrica elettronica o cartacea.

5. Gestione delle urgenze

Le urgenze odontoiatriche vengono gestite con priorità.

1. Il paziente viene identificato e valutato rapidamente.

2. L'odontoiatra stabilisce la priorità e la tipologia di intervento.

3. Dopo la prestazione, viene programmato il follow-up per la risoluzione definitiva.

6. Sicurezza e igiene

- Tutti gli ambienti vengono sanificati secondo protocolli giornalieri e tra un paziente e l'altro.
- Gli strumenti vengono sterilizzati in autoclave e tracciati mediante sistema di controllo.
- Vengono rispettati i protocolli di prevenzione del rischio infettivo (HBV, HCV, HIV, COVID-**19, ecc.).**

7. Documentazione e registrazioni

Le seguenti registrazioni devono essere mantenute:

- Schede anagrafiche e cliniche dei pazienti
- Consensi informati
- Registri di sterilizzazione
- Piani di manutenzione apparecchiature
- Registro smaltimento rifiuti sanitari

8. Miglioramento continuo

Il Direttore Sanitario valuta periodicamente:

- Soddisfazione del paziente
- Non conformità e segnalazioni
- Aggiornamenti scientifici e normativi
- Necessità di formazione del personale

Eventuali azioni correttive o preventive vengono pianificate e documentate.

Mensilmente è prevista la revisione di una tabella riepilogativa contenente i disservizi riscontrati all'interno dello studio odontoiatrico, al fine di effettuare un'analisi statistica degli stessi, finalizzata alla predisposizione di eventuali azioni di indagine e intervento.

DESCRIZIONE MESE Numero di Rispetto al mese precedente
eventi Diminuiti Inalterati Aumentati
Disservizi dovuti a fuori uso
attrezzature
Ritardi erogazione prestazioni
dovute a indisponibilità
personale di studio
Appuntamenti non rispettati da
parte del pubblico giustificati
Appuntamenti non rispettati per
insufficiente comunicazione e/o
chiarezza da parte della segreteria
Disservizi dovuti a guasti impianti
Disservizi dovuti a
guasti/indisponibilità
sistema informatico

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 6:

Piano per la gestione delle emergenze

Cod. Requisito
1A.02.02.02

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 6

Cod. Requisito 1A.02.02.02 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

PIANO PER LA GESTIONE

DELLE

EMERGENZA

Ultima revisione: ____/2026

Datore di Lavoro DOTT.SSA BARBARA SABIU

R.L.S. _____

Addetto all'antincendio ed emergenze DOTT.SSA BARBARA SABIU

1

Il presente Piano di Emergenza si basa su istruzioni scritte e chiare, ed è rivolto a tutte le persone presenti all'interno dei locali indicati.
Al suo interno sono definite specifiche funzioni e responsabilità, assegnate al personale strutturato con ruolo attivo nella gestione e nel contenimento dell'emergenza.
L'organizzazione interna è regolamentata secondo lo schema riportato di seguito.

Responsabile dell'emergenza: DOTT.SSA BARBARA SABIU

Responsabile delle chiamate: DOTT.SSA BARBARA SABIU

ATTENZIONE

Chiunque appartenga alla Squadra d'Emergenza o ricopra un ruolo importante per l'attuazione di Questo PIANO D'EMERGENZA

NONDIMENTICHIche:

■ NON DEVE combattere il fuoco al di sopra delle sue possibilità
■ DEVE preoccuparsi di tenersi sempre libera una via di fuga
■ AL PRIMO segnale di malessere deve portarsi FUORI dalla zona di pericolo
■ DEVE raggiungere gli altri al luogo di ritrovo sicuro e, SE POSSIBILE, attribuisca ad un altro i suoi incarichi preoccupandosi come PRIMA COSA di se stesso.

NUMERI TELEFONICI UTILI

SOCCORSOPUBBLICO: 113

CARABINIERI: 112

VIGILIDELFUOCO: 115

EMERGENZASANITARIA: 118

2

PREMESSA

La presente relazione è stata redatta in base al D.M. 03/07/2021 "Decreto Mini codice" in attuazione al disposto dell'art. 46 del D. Lgs. 81/08 smi relativo ai criteri divalutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed in genere delle emergenze emisure di prevenzione e protezione da adottare, al fine di definire le misureorganizzative e gestionali da attuare.
Scopo di questo "Piano di emergenza" è quello di fornire semplici informazioni suicomportamenti da adottare in caso di emergenza. In esso s'individuano i possibiliscenari incidentali nonché, tutte quelle azioni e procedure che devono attuarsi inconseguenza dell'evento sinistrorso.
Per "emergenza" s'intende il verificarsi di una situazione di pericolo, che puòcoinvolgere persone e/o cose, arrecando danni.
Obbligo del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall'Art. 18 del D.Lgs. 81/08, nonché dal

decreto di attuazione D.M. 03/07/2021 “Decreto Minicodice”, rimane:

1) attuare e rendere operativi tutti i necessari rapporti con i servizi pubblicicompetenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio egestione dell’emergenza;
2) nominare, tra il personale, coloro che in caso di emergenza abbiano il compito diattuare le idonee misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, dievacuazione in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di prontosoccorso e, comunque di gestione dell’emergenza;
3) rendere edotti, tutti coloro che possono essere esposti ad un pericolo grave edimmediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
4) in caso di pericolo grave ed immediato, pianificare e programmare in formapreventiva ogni intervento, affinché tutti possano cessare ordinatamente leproprie attività, abbandonandoimmediatamente il luogo di lavoro, verso aree sicure.

Questo Piano di Emergenza, deve essere portato a conoscenza di tutti coloro i qualihanno un ruolo attivo ai fine dell’attuazione dello stesso, pertanto esso sarà oggetto di riunioni periodiche propedeutiche alla sua promulgazione e diffusione al personale.
Deve inoltre essere facilmente fruibile per essere consultato da chiunque n’abbiainteresse alla sua attuazione, oltre ad essere reso disponibile agli organismi di controlloe vigilanza.
Questo elaborato non ha scadenza, ma deve essere necessariamente aggiornato.
Ogni qualvolta vi siano variazioni sostanziali tali da non renderlo più attuale.

Caratteristiche degli ambienti di lavoro:

TIPO ATTIVITA’ Studio odontoiatrico
CLASSE DI RISCHIO INCENDIO Bassa
DURATA CORSO ADDETTI 4 ore con aggiornamento quinquennale di 2 ore

ANTINCENDIO

ESTINTORI N.3 aCO2da5kg
VIE DI ESODO Su luoghi sicuri all’esterno. Idonee al massimo
Affollamento ipotizzabile – max percorrenza <1min
NUMERO DI LAVORATORI E Collaboratori oltre il pubblico (circa 3 persone)

PERSONE PRESENTI

LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI Nessuno

PARTICOLARI

ADDETTI ALLA PREVENZIONE DOTT.SSA BARBARA SABIU

INCENDI, ED ALLA EVACUAZIONE

ADDETTI ALLE EMERGENZE DOTT.SSA BARBARA SABIU

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO DOTT.SSA BARBARA SABIU

3

Scopo del piano

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) ha lo scopo di definire le procedure e i comportamenti da adottare in caso di emergenza (incendio, fuga di gas, terremoto, malore, ecc.)

all’interno dello studio odontoiatrico, al fine di:

- Salvaguardare la vita e la salute delle persone presenti;
- Limitare i danni alle strutture, alle apparecchiature e ai materiali;
- Garantire un’evacuazione ordinata, rapida e sicura;
- Agevolare l’intervento dei soccorsi esterni.

Campo di applicazione

Il piano si applica a tutti i locali dello studio odontoiatrico, compresi:

- Sale operative e di sterilizzazione
- Sala d’attesa
- Uffici
- Servizi igienici e locali tecnici

Riferimenti normativi

- D.Lgs. 81/2008 – Sicurezza nei luoghi di lavoro
- D.M. 10/03/1998 – Criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
- D.M. 02/09/2021 – Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio e in emergenza

Identificazione dei rischi di emergenza

I principali rischi che possono richiedere l'attuazione del presente piano sono:

- Incendio o principio d'incendio
- Fuga di gas o sostanze chimiche (es. disinfettanti, ossigeno, anestetici)
- Corto circuito o guasti elettrici
- Evento sismico
- Malore o infortunio grave di pazienti o operatori
- Minaccia esterna o evento imprevisto (es. allagamento, vandalismo, blackout)

Mezzi e presidi antincendio presenti

- Estintori a CO■ e/o polvere (uno ogni 150 m² o 30 m di percorso)
- Segnaletica di sicurezza conforme D.Lgs. 81/08
- Illuminazione di emergenza automatica
- Cassette di pronto soccorso e presidi sanitari
- Planimetria di evacuazione affissa in punti visibili.

4

1. SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE E DEI SISTEMI DI SICUREZZA

I sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti necessitano di una corretta gestione emanutenzione.
Per gestione s'intende l'insieme delle operazioni atte a garantire nel tempo un grado diaffidabilità sufficiente per il corretto funzionamento in caso di situazioni di emergenza.In particolare, nella gestione antincendio un'importanza fondamentale riveste lamanutenzione, oltre ad un'attenta attività **di controllo e verifica riguardante:**

- Estintori;
- Uscite di sicurezza;
- Luci di emergenza;
- Pulsanti di sganci o corrente elettrica;
- Pulsanti di allarme;
- Dispositivi di protezione individuali antincendio

Inoltre devono essere tenute sotto costante controllo i seguenti dispositivi:

- Segnaletica di emergenza;
- Agibilità delle vie di fuga;
- Materiale di primo soccorso;
- Dispositivi di protezione individuale;
- Stoccaggio prodotti chimici;
- Igiene degli impianti elettrici;
- Ordine generale.

2 CLASSIFICAZIONE DELLE EMERGENZE
Si definisce emergenza, un fatto anormale che può costituire fonte di grave pericoloper il personale o per gli impianti.
Le principali situazione di pericolo sono:

- Incendio
- Esplosione
- Allagamenti dovuti alla rottura di impianti
- Mancanza di energia elettrica
- Persona in grave pericolo
- Infortunio grave
- Eventi naturali (alluvioni, terremoti,)

Nel seguito di questo documento, saranno esaminate le situazioni che s'intendono dipericolo maggiore, poiché potenzialmente ad elevato rischio (incendio, allagamento, fughe di gas, terremoto).

5

L'efficace gestione della situazione di emergenza, non può prescindere dallacomprensione e dalla natura dell'emergenza stessa. Per questo motivo, in genere, risulta utile classificare le emergenze come **segue:**

A) Emergenza di livello lieve
L'emergenza può essere affrontata e controllata dal personale preposto, nonrichiede l'intervento della forza pubblica.

B) Emergenza di livello medio
L'emergenza è ancora affrontabile come nel caso precedente, ma con undispiego di "forze interne" notevoli. E' opportuno in questo caso, avvisare le forzepubbliche di pronto intervento (Vigili del Fuoco, Carabinieri). Tale preavviso è fondamentale nel caso in cui si perda il controllo delle situazioni.

C) Emergenza di livello grave
Questo tipo di emergenza deve essere affrontata esclusivamente mediante l'intervento delle forze pubbliche di pronto intervento.

3. FIGURE RESPONSABILI PER L'ESECUZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA

Di fronte ad una situazione riconosciuta "di emergenza", alcuni membri del personale sono eletti e designati come elementi facenti parte della "Squadra di Emergenza".
Ogni figura della Squadra di Emergenza, dovrà conoscere perfettamente il proprio ruolo e compito durante l'evento.
Ogni elemento avrà, tra gli altri, il principale compito di invitare il resto del personale presente a tenere la calma: questo fattore è determinante al fine di garantire un ordinato svolgimento delle operazioni previste da questo piano di emergenza.

Deve pertanto provvedersi preventivamente, alla nomina delle seguenti figure:

- Responsabile emergenza
- Responsabile chiamate
- Addetti antincendio

(che abbiano seguito con profitto un corso di formazione ai sensi del T.U. 81/08 e delD.M. 10/03/98).

- Addetti primo soccorso

(che abbiano seguito con profitto un corso di formazione ai sensi del T.U. 81/08 e delDecreto Interministeriale in materia di pronto soccorso in azienda)
Gli elementi della Squadra, devono essere coadiuvati da sostituti che, in caso di loro assenza, sono preposti allo svolgimento delle citate procedure in caso emergenza.

3.1 RESPONSABILE DELL'EMERGENZA E PROCEDURE DA SEGUIRE IN STATO DI NONEMERGENZA

Il Responsabile dell'Emergenza è la figura incaricata alla gestione dell'emergenza.
Il Responsabile dell'Emergenza o il suo sostituto, avrà pertanto il compito di gestirel'evolversi dell'intera emergenza. Sarà compito di questa figura, proclamare lo stato diinizio emergenza e di fine emergenza, l'ordine di evacuazione, ecc
Se nel corso dell'emergenza sono presenti sia il responsabile designato, che il suosostituto, entrambi collaboreranno al coordinamento delle procedure prescritte.
In caso di assenza contemporanea del responsabile designato e del suo sostituto, l'eventuale situazione di emergenza, viene condotta da un addetto antincendio.

6

Nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni, l'attività dei facenti parte dellasquadra addetta all'emergenza, non si limita solo esclusivamente durante le fasi di unmalaugurato evento sinistro, bensì si prolunga nel tempo sottoforma di prevenzione.

Durante il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ossia in condizione di NONEMERGENZA, il

Responsabile dell'Emergenza ha il compito di:

a) vigilare sulla praticabilità delle vie di esodo;
b) verificare periodicamente la completezza degli organici preposti all'emergenza;
c) verificare periodicamente il "livello di addestramento del personale";
d) organizzare le simulazioni relative all'emanazione di emergenza;
e) collaborare con il Servizio di Prevenzione e Protezione;
f) informare chi ha redatto il Piano di Emergenza di qualsiasi variazione strutturale ed organizzativa che possa alterare le condizioni di sicurezza previste nello stesso;
g) presiedere ed organizzare le periodiche riunioni sulla sicurezza.

Per una corretta gestione dell'emergenza, QUOTIDIANAMENTE, è necessario che egliconosca perfettamente il numero del personale presente.
E'pertanto opportuno rendere disponibile un registro aggiornato, dove si riportanogiornalmente i lavoratori presenti.

3.2 RESPONSABILE CHIAMATE E PROCEDURE DA SEGUIRE IN STATO DI NON EMERGENZA

Il Responsabile Chiamate rappresenta l'elemento all'interno dell'azienda, che ha ilcompito di effettuare le chiamate telefoniche in caso di emergenza.
Egli comunica i preposti al soccorso; fornendo loro tutte le informazioni sulla emergenzacomunicate

dai Responsabili e/o Addetti.
Periodicamente aggiorna e verifica l'elenco dei numeri telefonici d'emergenza, comunicando le variazioni alla squadra di emergenza.

3.3 ADDETTI ANTINCENDIO E PROCEDURE DA SEGUIRE IN STATO DI NON EMERGENZA

Collaborano con le squadre dei VV.FF. durante la fase di emergenza; in particolaremodo deve sapere

dare informazioni su:

■ l'esatta ubicazione dei presidi antincendio e di emergenza,
■ la locazione quadri elettrici generali e secondare,
■ l'eventuale presenza di linee sotto tensione, attivate da sistemi di generazionesecondari o tampone,
■ possibili cause generatrici dell'incendio,
■ eventuale tipologie di materiali stoccati al momento del sinistro.

In stato di NON EMERGENZA, gli addetti antincendio hanno il compito di:

a) controllare periodicamente (almeno una volta al mese) l'efficienza dei presidiantincendio:

■ carica degli estintori;
■ controllo della fruibilità dei percorsi di esodo;
■ controllo e verifica dell'impianto di illuminazione d'emergenza;
b) segnalare a chiunque la presenza dei divieti vigenti (ad esempio "VietatoFumare");
c) assicurarsi che le vie di esodo, le uscite di emergenza, i presidi antincendio e diemergenza, siano sempre tenuti sgombri ed accessibili.
Uso corretto e manutenzione della cartellonistica di emergenza

7

I cartelli ed i dispositivi segnaletici devono essere:

■ posizionati appropriatamente e non coperti da ostacoli, in rapporto all'obiettivo
■ bene illuminati ed in caso di cattiva illuminazione a colori fosforescenti,rifrangenti o ad illuminazione artificiale
■ rimossi se non più necessari
■ controllati, riparati, se necessario sostituiti, sottoposti a manutenzione affinché conservino le loro proprietà intrinseche; bisogna prevedere una periodicità neicontrolli per quelli alimentati da una fonte di energia
■ garantiti da una alimentazione di emergenza se funzionanti a mezzo di fonte di energia in numero adeguato; non esiste un numero preciso se non in funzione dei rischie dell'area da coprire.

Incompatibilità:

■ Non utilizzare contemporaneamente due segnali luminosi che possano confondersi.
■ Non utilizzare un segnale luminoso nelle vicinanze di un'altra emissione luminosa poco distinta.
■ Non utilizzare contemporaneamente due segnali sonori.
■ Non utilizzare un segnale sonoro se il rumore di fondo è troppo intenso.

Marcatura:

La segnaletica di sicurezza non richiede o prevede nessun tipo di marcatura checonfermi la conformità a qualsiasi standard nazionale o estero relativo allecaratteristiche sopra elencate.
Restano obbligatorie tutte le marcature previste per dispositivi sottoposti anormative diverse da quelle citate e che si riferiscono alle caratteristiche intrinseche del prodotto (bassa tensione, compatibilità elettromagnetica, bande di frequenza oper zone a rischio di esplosione).

3.4 ADDETTI PRONTO SOCCORSO E PROCEDURE DA SEGUIRE IN STATO DI NON IN EMERGENZA.

Sono i responsabili delle operazioni di primo soccorso, intervengono sui feriti in attesa del personale medico esterno.
Sono a conoscenza della esatta ubicazione delle cassette sanitarie e possono, in caso di incidente, fare intervenire il locale presidio ospedaliero (118 "EMERGENZA SANITARIA").
Essi hanno inoltre il compito di verificare periodicamente l'efficienza e la completezza delle cassette sanitarie.

4. PROCEDURE OPERATIVE PIANO DI EMERGENZA

Nei paragrafi che seguono, sono riportate le riportate le procedure di caratteregenerale da rispettare durante le possibili situazioni di emergenza.

Le norme comportamentali e le procedure che vengono esposte, sono valide sia per iresponsabili ed addetti che per tutto il personale presente nei locali della sede.
Nello schema presente, a semplice titolo illustrativo, è possibile. Osservare le fasi chegeneralmente caratterizzano una situazione di allarme, dovuto al propagarsi di unincendio: si osservi in particolare, la necessità di dovere completare la fase dievacuazione della struttura interessata all'evento, entro i tempi di estensione "generalizzata dell'incendio (flash over). Se la fase di evacuazione si protrae in talefase, le conseguenze in termini di vite umane, possono essere disastrose. Si percepiscepertanto l'importanza assoluta della tempestiva segnalazione e localizzazione delfuoco, succeduta dall'immediata evacuazione.

Leggete attentamente le seguenti:

8

NORME DI PREVENZIONE

Familiarizzate con le seguenti procedure di prevenzione e protezione:

■ Localizzate vie di fuga e uscite di emergenza;
■ Osservate la posizione di pulsanti di emergenza, estintori e cassette di Primo Soccorso;
■ Ponete in evidenza i numeri telefonici di emergenza;
■ Non ostruite le vie di fuga o le uscite di emergenza;
■ Leggete e rispettate quanto riportato nelle cartellonistica esposta;
■ Tenete in ordine il vostro luogo di lavoro in modo tale che non possa rappresentare fonte di rischio;
■ NON FUMATE né usate fiamme libere di alcun tipo dove vi è pericolo di incendio;
■ Disponete i materiali facilmente infiammabili lontani da ogni possibile fonte di calore;
■ Gettate i fiammiferi e i mozziconi di sigaretta negli appositi cestini solo DOPO esservi ATTENTAMENTE assicurati che siano spenti;
■ NON sovraccaricate le prese di corrente;
■ Quando possibile spegnete le apparecchiature elettriche al termine della giornata;
■ Segnalate sempre tempestivamente il cattivo stato di apparecchiature elettriche o di prese di corrente;
■ Segnalate sempre tempestivamente ai Responsabili principi di incendio o piccoli incidenti accaduti, anche quando vi sembrano trascurabili.

FASI IN CUI SI PROPAGA UN INCENDIO

9

4.1 SEGNALAZIONE DELL'EMERGENZA

La gestione di una situazione di emergenza è compito esclusivo della squadra di emergenza.
Una volta accertata la gravità dell'evento, se opportuno, la squadra di emergenza procede alla gestione dell'eventuale evacuazione.
I membri della Squadra di Emergenza, hanno il compito di comunicare a TUTTO IL PERSONALE presente, il sancito ORDINE DI EVACUAZIONE.

Il livello di Emergenza che si prospetta, STABILITO DAL RESPONSABILE DELL'EMERGENZA determina il tipo di comportamento e di approccio all'evento, discriminando

tra icomportamenti da adottare in ogni diversa circostanza, in particolare si devericonoscere:

■ Emergenza di livello lieve
Evento di modesta entità, ad esempio piccolo incendio, da fronteggiare con ilpersonale della "Squadra di emergenza" senza prevedere l'evacuazione deipresenti.
■ Emergenza di livello medio
Evento di media entità in cui deve essere evacuata parte della struttura, ed in cuioccorre un notevole dispiego di forze interne; avvisare in questo caso le forzepubbliche di pronto intervento.
■ Emergenza di livello grave
Evento grave in cui è necessario evacuare l'intera struttura. Deve essere richiesto immediatamente l'intervento delle forze pubbliche.

In caso di evacuazione, è necessario:

1. Dirigersi immediatamente verso le vie di esodo consigliate e/o più vicine, senza correre;
2. Abbandonare effetti personali o documenti.
3. Non perdere tempo nell'aspettare colleghi o amici.
4. Se eventuali visitatori non sono già stati presi in consegna da elementi dellasquadra di emergenza, condurli con se verso l'uscita di emergenza.
5. Raggiunto il punto di raccolta prestabilito, detto "Punto di Riunione", restare in tale area fino al termine dell'emergenza o fino a nuovo ordine da parte della squadra diemergenza.

6. Non sostare in aree dove sono installati mezzi di emergenza/antincendio e nonintralciare in nessun modo il lavoro delle forza di emergenza.
7. Tenere un comportamento ordinato, che non induca al panico se stessi ed il restodel personale.

4.3 PROCEDURE PER IL RESPONSABILE DELL'EMERGENZA DURANTE L'EMERGENZA

È compito del Responsabile dell'Emergenza:

1. Stabilire la natura dell'emergenza, optando per emergenza di livello:

- Lieve
- Medio
- Grave

2. Decidere se fare intervenire la squadra antincendio (se si tratta di incendio modesto).
3. Contattare telefonicamente (attraverso il Responsabile chiamate ed eventualmente anche personalmente) gli Enti pubblici di Pronto Intervento, comunicando la natura dell'emergenza (VV.F.F. tel. 115, Carabinieri Tel. 112, Soccorso Sanitario 118).

4. Decidere se dare il l'Ordine di Evacuazione.

5. Coordinare gli Addetti antincendio, premurandosi di:

- togliere tensione elettrica all'impianto (localizzare dalle planimetrie il quadroelettrico generale);

10

- verificare che l'illuminazione di emergenza, sia entrata in funzione.

6. Dirigere e coordinare, l'abbandono degli occupanti i locali attraverso le prefissatevie di fuga secondo i percorsi indicati in planimetria.

7. Organizzare, qualora necessario, percorsi di fuga alternativi.

8. In caso di evacuazione di portatori di handicap attenersi a quanto esposto nelparagrafo 4.8.
9. Provvedere all'appello nominale, attraverso il registro delle presenze, una voltaraggiunto il PUNTO DI RACCOLTA. Qualora del personale risultasse assenteall'appello, accertatosi dell'attendibilità della lista presenze, informare le squadre disoccorso (interne ed esterne) per iniziare la loro ricerca.

4.4 PROCEDURE PER IL RESPONSABILE CHIAMATE DURANTE EMERGENZA

È compito del responsabile delle chiamate:

1) Informare gli Enti Pubblici preposti al soccorso (secondo lo schema di seguitoallegato), seguendo le indicazione del Responsabile emergenza e/o degli Addettiantincendio.
Il contenuto del messaggio telefonico deve essere breve e esaustivo nei confrontidelle domande che **vengono poste, esempio:**

VIGILI DEL FUOCO 115

Sono il sig. . . . . , responsabile delle chiamate dello
STUDIO ODONTOIATRICO DEL DOTT, DOTT.SSA BARBARA SABIU

Via Ammiraglio Gravina n 9 San Giovanni Suergiu
E' in corso una situazione di emergenza a causa di un . . . . (incendio, esplosione, dissesto, crollo, ect) /
All'interno dei locali interessati all'incidente, sono presenti. . . . . .persone /
Sono presenti un numero di …… feriti, di cui ……..gravi/
L'area interessata dall'evento è un . . . . .(area limitata, intero piano, ect)

Seguire le disposizioni impartite dal Responsabile dell'Emergenza, tenendo informato il responsabile dell'emergenza.

4.5 PROCEDURE PER GLI ADDETTI ANTINCENDIO DURANTE EMERGENZA

È compito della Squadra Antincendio:

1) Raggiungere il quadro generale, interrompendo l'erogazione di energia elettrica nella zona interessata dall'emergenza.
2) In caso di incendio, riconoscere la causa dell'incendio, agire prontamente sul principio d'incendio con i mezzi di estinzione più idoneo al caso (mobili, semimobili o fissi).
3) In caso di evacuazione, togliere tensione all'intera sede agendo sull'interruttore generale.
4) In caso di perdite di acqua, provvedere alla chiusura delle valvole di intercettazione. In caso di impossibilità della manovra, informare il responsabile delle chiamate, il quale contattare il il Comando Provinciale dei VV.F.F.

5) Agire prontamente su un principio d'incendio con i mezzi di estinzione in dotazione: non usare mai acqua su apparecchiature elettriche ancora sotto tensione, ne estintori a base di acqua

(SCHIUMOGENI).

6) In caso di terremoto, appena terminato il movimento tellurico provvedere a chiudere le adduzioni di acqua e gas.

7) Qualora si presenti il caso di individuo in fiamme:

11

- Invitare alla calma, bloccando con decisione l'individuo, provvedendo adattaccare le fiamme soffocandole mediante coperte (preferibilmente inumidite) o mediante qualsiasi altro indumenti;
- inondare l'individuo con acqua;
- se non è possibile il rapido reperimento di coperte, qualsiasi abiti o indumenti, fare rotolare per terra la persona coinvolta;
- L'utilizzo dell'estintore è ammesso, solo se trattasi di ESTINTORE A POLVERE (evitando di dirigere il getto verso parti del corpo scoperte), non usare maiestintori caricati a CO2. (se presenti)

8) Coordinare l'ordinato sgombero dei locali.
9) Invitare il personale presente a proteggere le vie respiratorie con fazzolettiinumiditi, qualora le vie di fuga risultassero pervase dal fumo.
10) In attesa dell'arrivo dei soccorritori effettuare una rapida ricognizione peraccertare la presenza di persone all'interno dei locali (in particolare servizi, localiaccessori, etc.).
11) Informare i soccorritori sull'esatta ubicazione dei presidi antincendio ed indirizzarlisul particolare tipo di incidente.

4.6 PROCEDURE PER GLI ADDETTI PRIMO SOCCORSO DURANTE L'EMERGENZA

È compito degli addetti al primo soccorso:

1. Richiedere, d'accordo con il responsabile dell'emergenza, l'intervento del personale medico (118

"EMERGENZA SANITARIA").

2. Invitare alla calma gli eventuali feriti, prestando i primi medicamenti, in attesa del personale medico esterno.
3. Informare il personale medico esterno del tipo di evento subito dagli infortunati, precisando i medicamenti già adoperati sugli stessi (bendaggi di fortuna, medicinali, ect)

4.7 PROCEDURE COMPORTAMENTALI PER TUTTO IL PERSONALE DURANTE LE EMERGENZE

Ogni situazione di emergenza, si presenta in modo che difficilmente può essere prevista.
Al fine di preservare il più possibile l'incolumità della vita umana, è necessario che ogni elemento presente nell'area sinistrata, assuma atteggiamenti che siano il più possibile rapidi ed efficaci. Ciò è realizzabile solo attraverso una diffusa consapevolezza di una gestione ORDINATA dell'emergenza da parte di TUTTI.
E necessario dunque rendere complementari le procedure comportamentali elencate in precedenza per valide i Responsabili / Addetti, con i comportamenti tenuti dal resto del personale presente.

Per quanto detto, il personale presente nel luogo dove si è generata la condizione di emergenza, deve:

In Caso di Incendio:

1) Appena si rileva la presenza di un incendio (o principio di incendio), informare ilResponsabile dell'emergenza o gli Addetti antincendio e procedereall'attivazione dei segnali d'allarme.
2) Rispettare le disposizione fornite dalla squadra di emergenza.
3) Assistere le persone non autosufficienti ed allontanarsi dalla zona interessata edalle zone potenzialmente pericolose.
4) Non utilizzare acqua sugli apparecchi elettrici sotto tensione, utilizzare gli estintoricon cognizione delle loro caratteristiche.
5) In caso di locali densi di fumo, proteggere le vie respiratori, rimando bassi sulpavimento, guadagnare l'uscita.
6) Portarsi nei posti di raccolta, senza intralciare l'opera dei soccorritori, segnalando la propria presenza e l'eventuale assenza di terzi impossibilitati per qualunque motivo.

12

In Caso di Allagamento:

1) Attenersi esattamente alle indicazioni fornite dalla squadra di emergenza.
2) Interrompere, se possibile, l'erogazione dell'energia elettrica (per i responsabili/addetti), verificando che l'acqua non abbia raggiunto quadri.
3) Accertarsi che nessuna persona sia rimasta isolata in locali interessatidall'allagamento.
4) Verificare se vi sono cause accertabili di perdite di acqua - rubinetti aperti, visibilirotture di

tubazioni (per i responsabili / addetti).

In Caso di Terremoto:

1) Mantenere la calma e NON MUOVERSI sino a quando il sisma è finito.
2) Durante il sisma, se si è all'interno dell'edificio rimanerci, disponendosi sottoscrivanie, architravi.
3) Una volta terminato il movimento tellurico, procedere ordinatamente allo sgomberodei locali.
4) È compito dei responsabili e degli addetti, verificare che nei servizi igienici e localiaccessori non siano rimaste persone bloccate.
5) È compito degli addetti al primo soccorso occuparsi di eventuali feriti.

5 PRESIDI ANTINCENDIO E DI EMERGENZA

L'impianto antincendio, di tipo mobile, è costituito in particolare da:

N. 3 – estintore a CO2 da 5 kg

5.1. TIPOLOGIA DI RISCHIO ATTIVITA'

Da quanto emerge dalle caratteristiche del locale in oggetto, in relazione con il tipodi attività che

viene svolta (numero lavoratori, attrezzature e sostanze utilizzate, ecc),si può affermare che:

Lo studio odontoiatrico in oggetto, ai sensi dell'allegato IX del decreto ministeriale 10 marzo 1998 "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro", ed il d.m. 18/09/02 "approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la

costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private" è individuabile come:

ATTIVITA' A RISCHIO INCEDIO BASSA

Tutto il personale deve ricevere adeguata formazione antincendio, basata nei tempi e nei contenuti teorico-pratici, individuati all'allegato X del D.M. 10/03/98.
Inoltre, per quanto stabilito dall'allegato 1 di cui all'art. 2 comma 2 del D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 (in particolare al n. 68: Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq), l'attività in oggetto.

PERTANTO NON RIENTRA

Tra le attività per cui è necessario richiedere il parere preventivo dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco con il susseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Ai fini del presente piano d'emergenza si definiscono:

13

- LUOGO SICURO: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di unincendio;
- PERCORSO PROTETTO: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro glieffetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio.
- USCITA DI PIANO: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormenteesposte al rischio

diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

● uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
● uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essereraggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
- VIA DI ESODO (da utilizzare in caso di emergenza): percorso senza ostacoli al deflussoche consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

6. PRESIDI DA INSTALLARE ED OPERAZIONI DA COMPIERE AI FINI DELLA

SICUREZZA

Per potere gestire al meglio le eventuali situazioni di emergenza che si possonopresentare, sono installati alcuni presidi all'interno dei locali atti a definire delleoperazioni preventive da compiere ai fini della sicurezza.

Nei locali aziendali, si è pertanto provveduto a:

a) affliggere un numero sufficiente di planimetrie con l'indicazione delle vie di esodo, l'ubicazione degli estintori, del quadro elettrico generale, del posto telefonico per lechiamate esterne (insieme alle indicazioni grafiche saranno indicate le normecomportamentali di sicurezza in condizioni di emergenza);
b) l'individuare delle aree di riferimento esterne all'edificio da utilizzare come zona diraccolta;

Queste aree sono scelte, in modo da essere:

- sufficientemente distanti dall'edificio;
- sicuri e protetti dal traffico stradale;
- un riferimento sicuro e conosciuto;
- di non intralcio per lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

c) Affiggere idonea segnaletica di emergenza;
d) Istallare una adeguato sistema di illuminazione autonomo di emergenza.
L'importanza di un opportuna segnaletica d'emergenza, è stata analizzata danumerosi studi i quali hanno analizzato la psiche umane nelle condizioni di panico.

7. PROVA DI EVACUAZIONE

Almeno al biennio l'azienda deve organizzare la Prova di Evacuazione, resaobbligatoria dallo stesso decreto antincendio, attenendosi al seguente schema.
La Prova sarà condotta e coordinata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione eProtezione, con l'ausilio della Squadra di Emergenza.
Gli Addetti all'Antincendio interverranno con gli estintori là dove la prova verta sullospegnimento di un evento di tipo comunque controllabile, contrariamente siprovvederà ad avvertire i Vigili del Fuoco.
Gli Addetti al Primo soccorso lo faranno laddove venga richiesto un loro intervento aseguito di contusioni, traumi, abrasioni, ustioni causate da eventi come crolli, inondazioni, incendi.
Gli Addetti alle Emergenze, cureranno la correttezza delle procedure esplicate durantele varie fasi

della simulazione che sono, nella fattispecie:

- il presidio delle uscite di emergenza e dei cancelli adibiti ad ingresso, così daorientare i mezzi di soccorso diretti nell'insediamento;
- il disinnesco dell'energia elettrica;

14

- L'avviso a voce di tutto il personale anche (o in sostituzione) dopo l'eventuale suono delle sirene di evacuazione;
- La messa in sicurezza, ove sia possibile, di alcuni beni aziendali esposti a rischio;
- La concentrazione del personale nei luoghi di lavoro in sicurezza;
- L'uscita dallo stabile dello stesso personale.

Uno specifico verbale firmato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dai componenti la Squadra di Emergenza, dal Rappresentante dei Lavoratori per laSicurezza, dovrà sancire l'avvenuta effettuazione della prova simulata che andràripetuta sino a che tutti gli ingranaggi del meccanismo non abbiano funzionatoperfettamente.

Ricordiamo che la Prova di Evacuazione va ripetuta almeno ogni due anni, e che ilregime sanzionatorio è quello di cui al Dlgs 81/08, coordinato con il DLgs 106/09 e s.m.i.per ciascuna delle

seguenti inadempienze:

- Piano di Emergenza mancante.
- Valutazione del Rischio Incendio mancante.
- Mancata effettuazione della prova di evacuazione.

Conclusioni
Il Presente PIANO DI EMERGENZA è stato redatto aNovembre 2025 ed èsoggetto alla revisione periodica in base alle variazioni organizzative, agli aggiornamenti normativi ed al progresso tecnico.

Perapprovazione:

firma del Datore di Lavoro _____

firma del R.S.P.P. _____

firma del Responsabile dell'Emergenza _____

firma del R.L.S. _____

15

VERBALE PROVA PERIODICA SIMULATA DI EMERGENZA GENERALE

In data …… dalle ore ……. alle ore …… è stata effettuata la provaperiodica

simulata di emergenza generale secondo quanto prescritto dal Piano diEmergenza.

Funzioni e persone coinvolte:

_____

_____

_____

_____

Esito della prova e comportamento delle Funzioni interessate e del Personale:

_____

_____

_____

Tipo di segnale usato: _____

Tempi di evacuazione: _____

Osservazioni eventuali: _____

Firma per presa visione del personale dipendente _____

Firma per presa visione dei collaboratori_____

DataILRESPONSABILE

16

INDICE

1 Sorveglianza e controllo delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza
2 Classificazione delle emergenze
3 Figure responsabili per l'esecuzione delle misure di sicurezza
3.1 Responsabile emergenza e procedure da seguire in stato di non emergenza
3.2 Responsabile chiamate e procedure da seguire in stato di non emergenza
3.3 Addetti antincendio e procedure da seguire in stato di non emergenza
3.4 Addetti pronto soccorso e procedure da seguire in stato di non emergenza
4 Procedure operative Piano di Emergenza
4.1 Segnalazione dell'emergenza
4.2 Evacuazione
4.3 Procedure per il Responsabile dell'emergenza durante le emergenze
4.4 Procedure per il Responsabile delle chiamate durante le emergenze
4.5 Procedure per gli Addetti antincendio durante le emergenze
4.6 Procedure per gli Addetti primo soccorso durante le emergenze
4.7 Procedure comportamentali per tutto il personale, durante le emergenze
5 Descrizione della struttura
5.1 Presidi antincendio e di emergenza
5.1.1. Tipologia di rischio attività
6 Presidi da installare ed operazioni da compiere ai fini della sicurezza
7 Prova di Evacuazione
8 Elenco dei responsabili / addetti per la gestione delle emergenze
8.1 Elenco del personale

Allegati

- Planimetrie con vie di fuga, uscite di emergenza e presidi antincendio
- Elenco aggiornato del personale e ruoli in emergenza
- Istruzioni nell'utilizzo dei sistemi di emergenza
- Attestati del personale
- Registro prove di evacuazione
- Schede di verifica estintori e impianti

17

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 7:

Protocollo per l'isolamento di pazienti con patologie contagiose o potenzialmente tali

Cod. Requisito
1A.02.02.03

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 7

Cod. Requisito 1A.02.02.03 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Il presente protocollo intende definire le raccomandazioni per le misure di isolamento da adottare per i pazienti con patologie contagiose o potenzialmente tali.

DEFINIZIONI:

Isolamento: misura adottata per contenere la diffusione delle infezioni, che consiste nella separazione fisica della fonte di infezione dai soggetti suscettibili. In ambiente ospedaliero, l'isolamento coincide con il ricovero di un paziente fonte di infezione in un locale adeguato e separato dagli altri pazienti con patologie diverse.

Serbatoio di infezione: soggetto (infetto o portatore) oppure ambiente in cui il microrganismo sopravvive e si moltiplica.

Fonte di infezione: luogo da cui proviene il microrganismo infettante. In alcuni casi, il serbatoio e la fonte di infezione coincidono (ad esempio Staphylococcus aureus e mucosa nasale), mentre in altri casi serbatoio e fonte di infezione sono differenti (ad esempio nella salmonellosi).

■ Ospite suscettibile: soggetto che, venendo a contatto con un microrganismo, sviluppa la malattia infettiva. Le difese dell'ospite possono essere alterate da diverse condizioni patologiche, dall'età, da terapie antibiotiche, steroidee, immunosoppressive o radioterapiche, nonché da procedure diagnostiche e/o terapeutiche (cateteri, endoscopie, interventi chirurgici, ecc.). Per questo motivo, un soggetto può diventare suscettibile anche venendo a contatto con microrganismi generalmente non patogeni.

Trasmissione: passaggio dell'agente infettivo dal serbatoio o dalla fonte di infezione all'ospite.

Le principali modalità di trasmissione delle infezioni sono:

■ Per contatto diretto: avviene attraverso un contatto immediato tra la fonte di infezione e l'ospite.
Esempio: durante attività di assistenza che richiedono il contatto diretto dell'operatore con liquidi biologici del paziente (mobilizzazione, igiene personale)

Esempio di infezioni: infezioni a trasmissione parenterale.

■ Per contatto indiretto:

o Attraverso veicoli: avviene tramite il contatto tra un ospite suscettibile e un oggetto contaminato da microrganismi (veicolo di infezione), come strumenti chirurgici, manipoli, specilli, aghi, guanti.
o Attraverso vettori: avviene quando il vettore (insetto o macroparassita in genere) partecipa attivamente alla trasmissione dell'infezione.
■ Attraverso droplets: il microrganismo si trasmette dalla fonte o dal serbatoio di infezione mediante particelle chiamate droplets (goccioline), eliminate con la tosse, gli starnuti o durante l'utilizzo di strumenti rotanti ad alta velocità. Le goccioline si depositano sulle mucose dell'ospite.
Questo tipo di trasmissione avviene solo se l'ospite si trova a distanza ravvicinata dalla fonte di infezione.
Esempi: Neisseria meningitidis, virus influenzali.
■ Per via aerea: la trasmissione per via aerea si verifica quando il microrganismo è in grado di diffondersi nell'aria attraverso la disseminazione di nuclei di goccioline (droplet nuclei) di dimensioni inferiori rispetto alle droplets, oppure mediante particelle di polvere contaminate.
In tal caso, il microrganismo può raggiungere anche lunghe distanze dalla fonte di infezione.
Esempi: Mycobacterium tuberculosis (TBC), morbillo, varicella.

MODALITA'OPERATIVE

La catena di trasmissione delle infezioni nosocomiali presuppone l'esistenza di una fonte o di un serbatoio di infezione da cui, direttamente o indirettamente, il microrganismo patogeno raggiunge l'ospite suscettibile.

Il presente protocollo si propone, a scopo di prevenzione primaria, di applicare le misure precauzionali indicate nelle Linee Guida dei principali organismi scientifici internazionali, in particolare quelle del Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

CAMPODIAPPLICAZIONE

Vi sono due livelli nelle precauzioni di isolamento:

1. Precauzioni destinate all'assistenza di tutti i pazienti in ospedale
→ Precauzioni standard

2. Precauzioni destinate all'assistenza di specifici pazienti

→ Precauzioni basate sulla modalità di trasmissione
o Precauzioni per la trasmissione aerea
o Precauzioni per la trasmissione attraverso goccioline (droplet)
o Precauzioni da contatto

Le "Precauzioni standard (S)" riguardano:

1. Misure di barriera

2. Strumenti / oggetti taglienti

3. Decontaminazione dello strumentario riutilizzabile

4. Biancheria

5. Pulizia e disinfezione ambientale

6. Collocazione del paziente

Le "Precauzioni basate sulla modalità di trasmissione" riguardano:

1. Precauzioni per la trasmissione aerea

2. Precauzioni per la trasmissione attraverso goccioline (droplet)

3. Precauzioni per la trasmissione da contatto

1. Precauzioni standard

1.1. Misure di barriera

1.1.1. Igiene delle mani

Il lavaggio delle mani è la misura più importante per ridurre il rischio di trasmissione di microrganismi da una persona all'altra o tra sedi diverse dello stesso paziente.
È non solo una misura di controllo delle infezioni, ma anche una misura di protezione dell'operatore.

Piccole lesioni di continuo sulla cute delle mani possono rappresentare una via di ingresso e una fonte o serbatoio di infezione; inoltre, le mani dell'operatore sono un potenziale veicolo di infezione.
Un efficace lavaggio delle mani è quindi la precauzione standard più incisiva nella riduzione delle infezioni in ambito odontoiatrico.

Il lavaggio delle mani deve avvenire:

■ Prima di ogni seduta con il paziente
■ Prima e dopo le procedure asettiche
■ Prima e dopo gli interventi chirurgici
■ Prima e dopo le medicazioni
■ Immediatamente, in caso di contatto accidentale con sangue, fluidi corporei, secreti, escreti o oggetti contaminati, anche se si indossavano i guanti
■ Dopo aver tolto i guanti
■ Dopo l'uso dei servizi igienici

Ulteriori indicazioni:

■ Lavare le mani dopo la rimozione dei guanti e tra un paziente e l'altro.
■ Utilizzare detergente normale per il lavaggio sociale (di routine) delle mani.
■ Utilizzare antisettico in circostanze specifiche, rispettando tempi di lavaggio di almeno 1–2 minuti.
■ I lavabi devono essere dotati di dispenser con detergente, antisettico e salviette di carta monouso.
■ Le unghie devono essere ben curate, corte e prive di smalto. Durante l'attività non portare anelli, bracciali o altri monili.

1.1.2. Guanti

■ Devono essere indossati guanti monouso sterili in lattice o vinile per le procedure che comportano contatto con aree del corpo normalmente sterili.
■ Devono essere indossati guanti monouso non sterili in lattice o vinile per le procedure che prevedono contatto con mucose o altre procedure diagnostiche o di controllo che non richiedono guanti sterili.
■ Devono essere indossati guanti in gomma per uso domestico per la pulizia ambientale e la decontaminazione dello strumentario.

I guanti devono essere:

■ Rimossi prontamente dopo l'uso.

■ Rimossi prima di assistere un altro paziente.
■ Sostituiti quando si rompono, si verifica una puntura o una lacerazione.
■ Dopo la rimozione dei guanti, lavare immediatamente le mani.

ATTENZIONE:

Indossare i guanti non sostituisce la necessità di lavare le mani, poiché:

1. I guanti possono presentare difetti invisibili o lacerarsi durante l'uso.
2. Le mani possono contaminarsi durante la rimozione dei guanti.

3. I guanti possono contaminarsi quando vengono indossati.

1.1.3. Mascherine, occhiali protettivi / visiere

■ Devono essere utilizzati durante le procedure che possono determinare schizzi di sangue o di altri liquidi biologici.
■ La mascherina deve essere sostituita ad ogni paziente e comunque non oltre un'ora di impiego, quindi gettata nel contenitore dei rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

1.1.4. Camici

■ Devono essere utilizzati camici in cotone pesante o camici in TNT per proteggere la cute e prevenire l'imbrattamento degli indumenti, riducendo la trasmissione di microrganismi durante procedure che possono determinare schizzi di sangue o altri liquidi biologici.
■ Dopo aver tolto il camice, lavare le mani.

1.2. Strumenti / oggetti taglienti

Per prevenire incidenti causati da aghi, bisturi e altri dispositivi taglienti o appuntiti:

■ Non reincappucciare gli aghi né rimuoverli manualmente dalle siringhe.
■ Non indirizzare la punta di aghi o altri oggetti taglienti verso parti del corpo.
■ Non raccogliere strumenti taglienti o appuntiti mentre stanno cadendo.
■ Non piegare o rompere lame, aghi o altri oggetti taglienti.
■ Eliminare sempre aghi e altri oggetti taglienti negli appositi contenitori per prevenire esposizioni accidentali.

1.3. Decontaminazione dello strumentario riutilizzabile

■ Tutto il materiale riutilizzabile venuto a contatto con sangue o altri liquidi potenzialmente infetti deve essere immerso subito dopo l'uso in soluzione disinfettante a base di derivati fenolici 0,4% per 30 minuti.
■ La pulizia dello strumentario va effettuata utilizzando mascherina con visiera e guanti.

■ I presidi medico-chirurgici critici o semi-critici contaminati vanno sterilizzati o disinfettati; la tipologia di disinfettante da utilizzare è determinata dallo strumento e dal suo uso specifico.

1.4. Pulizia e disinfezione ambientale

La pulizia e disinfezione degli ambienti ordinari deve essere effettuata quotidianamente, mentre per gli ambienti operativi è necessaria tra un paziente e l'altro.
Per alcuni microrganismi patogeni (es. enterococchi), che resistono a lungo nell'ambiente, occorre un'adeguata disinfezione delle superfici con cui il paziente è venuto a contatto (sedute, sale d'attesa, maniglie delle porte, rubinetti, ecc.).

1.5. Collocazione del paziente

La gestione separata del paziente, in orari stabiliti e preferibilmente a fine giornata, può essere

necessaria per:

■ Malattie a trasmissione aerea.
■ Pazienti con scadenti abitudini igieniche, non collaboranti o che contaminano l'ambiente (es. bambini o soggetti con alterazioni mentali).

La gestione separata riduce la possibilità di trasmissione e facilita l'adozione delle misure di profilassi da parte del personale.

1.6. Gestione pazienti con patologie contagiose o potenzialmente tali

Nel caso di:

■ Temperatura corporea superiore a 37°C
■ Insorgenza improvvisa di sintomi quali febbre, tosse, dispnea senza altra eziologia nota
■ Sintomatologia riconducibile a patologie contagiose
■ Riscontro di pediculosi o scabbia

Il paziente sarà temporaneamente isolato presso la seconda sala operativa e dotato di DPI **(mascherina FFP2 e guanti in lattice) in attesa di:**

■ Eventuale intervento del 118
■ Arrivo di un familiare per il prelievo del paziente

Gli altri pazienti in sala d'attesa dovranno allontanarsi per almeno 60 minuti per consentire le successive operazioni di sanificazione.

Si procederà quindi alla sanificazione immediata e straordinaria della sala d'attesa, sala operativa, studio privato e bagno (se utilizzati dal paziente), aerando i locali per almeno 20 minuti.
Particolare attenzione dovrà essere prestata agli oggetti venuti a diretto contatto con il soggetto, che andranno trattati con gli stessi prodotti e concentrazioni previste dal protocollo.

Se necessario, si procederà anche alla sanificazione dei filtri degli impianti di climatizzazione con ricircolo d'aria.

DPI richiesti per le operazioni di sanificazione:

■ Maschera FFP2
■ Guanti monouso
■ Tuta da lavoro monouso in TNT
■ Cuffia in TNT
■ Visiera
■ Scarpe da lavoro con copricalzari monouso

2. Precauzioni basate sulla modalità di trasmissione

Destinate ai pazienti riconosciuti o sospetti di essere infetti da patogeni altamente trasmissibili o epidemiologica mente importanti, diffusi per via aerea, tramite goccioline (droplets) o attraverso il contatto con cute o superfici contaminate.
Richiedono ulteriori precauzioni oltre a quelle standard.

2.1. Precauzioni per la trasmissione aerea

In aggiunta alle precauzioni standard, devono essere adottate per pazienti noti o sospetti di infezione da patogeni trasmessi da nuclei di goccioline aerodiffuse (droplet nuclei) che possono rimanere sospesi e diffondersi nell'aria (es. TBC, morbillo, varicella).

2.1.1. Mascherine

Il personale deve indossare mascherina di protezione respiratoria all'ingresso nella sala operativa.

■ Per pazienti con TBC: FFP2 per procedure di assistenza generali, FFP3 per procedure che inducono tosse o generano aerosol.
■ La mascherina non è necessaria per operatori immuni in caso di varicella o morbillo.

2.1.2. Educazione sanitaria

Istruire il paziente sulle norme igieniche da osservare per prevenire la diffusione di microrganismi ad altri degenti o all'ambiente (es. coprirsi naso e bocca con salviette monouso durante la tosse).

2.2. Precauzioni per la trasmissione attraverso goccioline (droplets)

In aggiunta alle precauzioni standard, queste misure si applicano ai pazienti infetti o sospetti di esserlo

per patogeni trasmessi da goccioline di dimensioni maggiori, generate da starnuti, tosse, conversazione o alcune manovre diagnostiche o terapeutiche (es. N. meningitidis, difterite faringea, H. influenzae, influenza, rosolia, pertosse).

2.2.1. Gestione del paziente

Per pazienti con patologie contagiose accertate o potenzialmente tali, rimandare l'appuntamento a dopo la guarigione.
In caso di urgenza, programmare la seduta come ultimo appuntamento della giornata.

2.2.2. Guanti e mascherina di protezione

Il personale deve indossare mascherina FFP2 quando lavora a meno di un metro di distanza dal paziente.

2.3. Precauzioni per la trasmissione da contatto

In aggiunta alle precauzioni standard, queste misure devono essere adottate per pazienti noti o sospetti di infezione da patogeni trasmissibili tramite contatto diretto (mani, cute, mucose) o indiretto (superfici, presidi). Esempi: affezioni gastrointestinali, ascessi, decubiti, scabbia, pediculosi.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 8:

Procedura che definisce i requisiti per la redazione, l'aggiornamento, la conservazione e la verifica della documentazione sanitaria nonche le modalita di controllo.

Cod. Requisito
1A.02.05.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 8

Cod. Requisito 1A.02.05.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Scopo:

Definire i requisiti e le modalità operative per garantire una corretta redazione, aggiornamento, conservazione e verifica della documentazione sanitaria dei pazienti, assicurando tracciabilità, riservatezza e conformità alle normative vigenti.

Documentazione:

Può essere in diversi formati (cartaceo o elettronico) e su diversi supporti.

In particolare la documentazione comprende:

- Cartella clinica;
- Consensi informati;
- Documenti di posta elettronica, compresi gli allegati.
- Gestione dei database informatici per radiografie digitali
- Documenti necessari allo svolgimento delle attività, come ad esempio, fotografie, esami radiografici

Struttura della documentazione
La documentazione riporta nell'intestazione ordinatamente il nome dell'azienda, con l'eventuale logo, il nome del documento, modulo o altro, il codice del documento ed il numero di pagina, riferito al numero totale di pagine. Per i moduli è ammesso omettere la numerazione delle pagine se sono tutti contenuti in un sola pagina.
Il piede di pagina riporta il nome del documento ed il percorso della cartella in cui è conservato, la data e l'indice di revisione.
Quando è possibile la documentazione deve riportare l'indice generale; nei documenti più importanti e più articolati è raccomandato anche un indice analitico da inserire alla fine del documento stesso e che contenga le voci più importanti.

Responsabilità della redazione
La redazione della documentazione sanitaria è compito del Titolare dello studio odontoiatrico, il Dott.ssa Barbara Sabiu. La redazione tiene conto per le specifiche pertinenze della normativa vigente sulla tutela dei dati personali, sul contenuto specifico (es. dati obbligatori e descrittivi della cartella clinica), sulla tutela radioprotezionistica (consenso informato)

Riesame ed Aggiornamento
Ad ogni incontro con il paziente l'Odontoiatra richiama la cartella clinica cartacea/informatizzata e la documentazione sanitaria a corredo (dagli archivi e/o dal software gestionale), e dopo averla visionata apporrà gli eventuali aggiornamenti datati che descrivono gli avanzamenti del piano di cura concordato. Gli stessi aggiornamenti saranno di conseguenza attribuiti all'Odontoiatra che effettua le prestazioni/indagini strumentali tramite sigla autografa o direttamente dal software gestionale del database per le quali sono state consegnate le credenziali di accesso personali dal Titolare
Gli aggiornamenti si rendono quindi necessari per uniformare la documentazione, e quindi le attività da essa supportate, al nuovo quadro clinico dovuto al progredire delle prestazioni erogate o in alternativa alla chiusura con relativa conservazione per almeno cinque anni della cartella clinica e di tutte le informazioni ad essa associate.

Conservazione della documentazione sanitaria
La conservazione della documentazione sanitaria (es. cartella sanitaria, preventivi, piano di cura, consenso informato, prescrizioni e terapia) in formato digitale è prevista all'interno software gestionali protetti da password gestite dal titolare e/o all'interno di carpette codificate in maniera da essere riconducibili in maniera univoca al paziente, custodite all'interno di armadi con serratura a chiave affidata al titolare.

La documentazione sanitaria può essere costituita da:

- Cartella clinica digitale gestita da programma gestionale
- Cartella clinica cartacea
- Consensi informati informatizzati
- Radiografie convenzionali digitalizzate
- Piani di cura informatizzati
- Email

La integrità è garantita da procedure di backup periodici su supporti removibili dedicati oltre che dalla presenza di un antivirus aggiornato e accesso ai dati consentito da password gestite dal Titolare. E' altresì presente un UPS che interviene in caso di interruzione della fornitura elettrica. La documentazione cartacea sanitaria è custodita in armadio dotato di serratura a chiave tenute dal Titolare. Se ritenuto necessaria è prevista la copia della documentazione per sicurezza di conservazione che sarà inserita presso altro armadio distinto.

La tutela dei dati personali si attua al livello fisico e al livello logistico. Per il primo è presente un locale segreteria ed un ufficio per la ricezione della clientela all'interno dei quali è rispettata la privacy durante i colloqui per le trattazioni sanitarie ed economiche. Il trattamento dei dati personali altresì per come previsto dalla normativa vigente viene concesso dal cliente tramite apposito consenso. La consultazione degli archivi digitali è consentito esclusivamente agli operatori odontoiatri dotati di apposite credenziali di accesso personali.

La attività odontoiatrica non prevede consegna ai clienti di referti. Copia della cartella clinica o copia delle indagini strumentali (radiografie) può essere comunque richiesta dall'interessato brevi manu o su delega in busta chiusa (e con documento di riconoscimento del delegante e del delegato in corso di validità) con a fine del trattamento tramite formale procedura scritta o via email e consegnata allo stesso con le stesse modalità con tempi previsti in una settimana.

Le cartelle cliniche sono firmate dal Titolare o suo collaboratore/consulente odontoiatra che ne cura la compilazione, e l'esecuzione delle indagini strumentali (eventuali radiografie) è consentito esclusivamente agli odontoiatri tramite software dedicato il quale abilita singolarmente gli stessi con credenziali personalizzabili. E' di conseguenza identificabile univocamente il responsabile della prestazione.

Tutti gli eventuali odontoiatri collaboratori coinvolti nel processo di redazione saranno formati ed informati delle procedure e relative responsabilità tramite incontri che saranno programmati al momento dell'inizio della collaborazione.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 9:

Documento formale di incarico del responsabile della Manutenzione

Cod. Requisito
1A.03.01.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 9

Cod. Requisito 1A.03.01.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Il sottoscritto Dott.ssa Barbara Sabiu, Odontoiatra, in qualità di Titolare dello studio odontoiatrico sito in San Giovanni Suergiu in Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU).
Al fine di garantire l'efficienza, la sicurezza e la conformità normativa delle attrezzature, degli impianti e delle strutture dello studio odontoiatrico, si rende necessario designare un Responsabile della Manutenzione incaricato di sovrintendere alle attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria e alla relativa documentazione, pertanto

NOMINA

Se stesso come Responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.

Compiti e responsabilità

Il Responsabile della Manutenzione ha il compito di:

1. Garantire l'efficienza e la sicurezza di tutti gli strumenti odontoiatrici, e delle apparecchiature elettromedicali, dei dispositivi ausiliari e degli impianti tecnici (elettrico, idrico, aspirazione, compressore, ecc.).
2. Garantire l'efficienza degli eventuali strumenti di radiologia, (contratto con esperto qualificato)
3. Pianificare e monitorare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, in accordo con le indicazioni dei produttori e le normative vigenti.
4. Tenere aggiornato il registro delle manutenzioni e archiviare i relativi rapporti d'intervento.
5. **Segnalare tempestivamente eventuali anomalie, guasti o rischi.**
6. Verificare la regolarità delle tarature e verifiche di sicurezza elettrica delle apparecchiature mediche.
7. Coordinare eventuali fornitori o tecnici esterni incaricati di interventi specialistici.

Firma:

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 10:

Inventario delle attrezzature aggiornato e verificato annualmente e procedura per l'identificazione delle attrezzature

Cod. Requisito
1A.03.02.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 10

Cod. Requisito 1A.03.02.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

ELENCO DELLE ATTREZZATURE e STRUMENTARIO

Il sottoscritto Dott. Francesco Teresi, nato a Palermo il 05/09/1996, residente in Misilmeri in via Nazionale n°67 titolare dello studio medico odontoiatrico privato, sito in San Giovanni Suergiu via Ammiraglio Gravina n° 9-11,

D I C H IAR O

che l'elenco delle attrezzature all'interno dello studio è il seguente:

■ **Locale tecnico:**

- Compressore
Marca: Cattani
Modello: Comp. 2c. LT 30 rosso
S/N: C2161289

(Riferimento in planimetria: 18)
- Aspiratore
Marca: Cattani
Modello: "Micro smart cube" + idro
S/N: WS203486

(Riferimento in planimetria: 19)
- Filtri legionella
Marca: Viroxidaqua
Modello: UF - Unit Pro 1
S/N: 070700

(Riferimento in planimetria: 21)

■ **Sala Sterilizzazione:**

- Autoclave
Marca: Faro
Modello: Nisea
S/N: 21BSTN10A100104

(Riferimento in planimetria: 22)
- Autoclave
Marca: Dental X
Modello: Domina Plus B
S/N: 0946PB

(Riferimento in planimetria: 23)
- Termosigillatrice
Marca: Euronda S.P.A
Modello: EurosealInfinity
S/N: EDS250104

(Riferimento in planimetria: 24)
- Distillatore
Marca: Faro
Modello: MH943T - SW

S/N: 739071

(Riferimento in planimetria: 25)
- Frigorifero farmaci
Marca: Atlantic
Modello: FM110
(Riferimento in planimetria: 26)
- Termopulitrice
Marca: Tecno-Gaz
Modello: Multisteril
S/N: 2013092VM

(Riferimento in planimetria: 27)

■ **Sala Operativa 1:**

- Diafanoscopio
Marca: Tecnogaz
Modello: 7085/N

S/N: NE7320109

(Riferimento in planimetria: 35)
- Miscelatore per impronte dentali
Marca: Aquasil
Modello: Duomix 276000

S/N: B00842

(Riferimento in planimetria: 37)
- Lampada fotopolimerizzante
Marca: Ivoclar
Modello: Bluephase G4 Grey

S/N: 1400000376

(Riferimento in planimetria: 38)
- Scanner intraorale
Marca: Medit I-700
Modello: MD – IS0200

S/N: AZ2404100100

(Riferimento in planimetria: 39)
- PC Notebook
Marca: HP OMEN 15
Modello: DC1050NL

S/N: 5CD0142DGK

(Riferimento in planimetria: 40)
- Micromotore chirurgico
Marca: Kavo
Modello: Expert surg lux 1.008.3500

S/N: 1016796

(Riferimento in planimetria: 41)
- Riunito
Marca: Anthos
Modello: A7 Plus continental

S/N: 71BX1581

(Riferimento in planimetria: 16)

■ **Sala Operativa 2:**

- Riunito
Marca: Castellini
Modello: Skema 5

S/N: 71LP1052

(Riferimento in planimetria: 16)
- Lampada sbiancamento dentale
Marca: Blu Dent
Modello: 12 BC

S/N: 016750

(Riferimento in planimetria: 42)

■ Dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine, occhiali, camici ecc.)

■ Materiali monouso (cannule di aspirazione, bicchieri, mantelline ecc.)

■ Strumentario necessario per l'attuazione delle diverse prestazioni odontoiatriche (conservatina, protesica ecc.)

■ Strumentario per estrattiva (pinze, leve ecc.)

■ Strumentario per parodontologia (curette, sonde ecc.)

■ Strumentario per conservativa (escavatori, otturatori ecc.)

■ Strumentario per endodonzia (strumenti canalari ecc.)

Altresì si dichiara che:

Il manuale uso e manutenzione delle attrezzature si trova all'interno dello studio in formato digitale e cartaceo.
L'inventario delle attrezzature si riferisce alla data di apertura dello studio odontoiatrico.
Lo stesso conterrà successivamente la eventuale data di modifica dello stesso.
DATA In fede
Dott. Francesco Teresi

Procedura per l'identificazione delle attrezzature

La presente procedura ha lo scopo di definire le modalità per l'identificazione, classificazione e tracciabilità delle attrezzature e apparecchiature presenti nello studio odontoiatrico, al fine di garantirne la corretta gestione, manutenzione e conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza e qualità.

La procedura si applica a tutte le attrezzature e apparecchiature in uso presso lo studio odontoia-
trico, comprese:

- Poltrone odontoiatriche e relative unità operative
- Compressori e aspiratori chirurgici
- Autoclavi e sistemi di sterilizzazione
- Apparecchi radiografici e radiografici digitali
- Dispositivi elettromedicali (lampade polimerizzatrici, ablatori, turbine, ecc.)
- Strumentazione diagnostica e di laboratorio
- Attrezzature informatiche collegate alla gestione clinica.

Modalità operative
Identificazione delle attrezzature

Ogni attrezzatura è identificata mediante:

- Etichetta o codice identificativo univoco, applicato in posizione visibile;
- **Scheda di identificazione contenente:**

o Codice attrezzatura
o Descrizione e marca/modello
o Numero di serie
o Data di acquisto o installazione
o Ubicazione (sala o reparto)
o Fornitore e contatti
o Scadenze di manutenzione/verifiche
o Eventuali note o limitazioni d'uso

Registro delle attrezzature
Tutte le attrezzature sono inserite nel Registro delle Attrezzature (cartaceo o digitale), mantenuto aggiornato dal Responsabile della Manutenzione.
Ogni nuova apparecchiatura sarà registrata prima dell'uso operativo.

Aggiornamenti

In caso di:

- Nuovo acquisto
- Dismissione
- Spostamento o rottamazione

il registro sarà aggiornato entro 5 giorni lavorativi e la scheda dell'attrezzatura archiviata.

Verifiche e manutenzioni

Le attrezzature saranno oggetto di:

- Verifiche periodiche di sicurezza elettrica e funzionale (secondo indicazioni del produttore o normativa vigente)
- Manutenzione preventiva e correttiva, registrata nella scheda di manutenzione.

Ogni intervento sarà firmato dall'esecutore (interno o esterno).

Identificazione di apparecchi fuori uso

Le attrezzature non operative o in manutenzione saranno chiaramente contrassegnate con cartello "FUORI SERVIZIO", per impedirne l'utilizzo accidentale.

Documentazione correlata

- Registro delle Attrezzature
- Schede di manutenzione e verifica periodica

- Rapporti tecnici di intervento
- Manuali d’uso e libretti di manutenzione

Archiviazione
Tutta la documentazione relativa alle attrezzature sarà conservata per almeno 10 anni dalla dismissione dell’apparecchiatura e archiviata in modo ordinato, accessibile solo al personale autorizzato.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 11:

Piano per la gestione e la manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle strutture, impianti, attrezzature e apparecchiature biomediche.

Cod. Requisito
1A.03.02.02

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 11

Cod. Requisito 1A.03.02.02 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

PIANO VERIFICHE

PERIODICHE

Strutture
- Ispezione visiva Annuale
- Tinteggiatura dei locali Quinquennale

Apparecchiature biomediche

biennale Autoclave:

- Vacuumtest – giornaliero
- Bowie and Dick mensile
- Helix Test mensile
- Testchimico: adogni ciclo

Impianto elettrico:

- Lampade di emergenza semestrale
- Intervento interruttori differenziali: annuale
- Continuità conduttori di protezione: triennale

Impianto antincendio: Estintori,semestrale
Impianto idrico Riserva idrica, sanificazione ogni tre mesi.
(vedi contratto con impresa “Pascale pulizie” allegato alla presente.)

Le verifiche periodichesopra el encat e sono sotto la Responsabilità del Titolare dello studio odontoiatrico Dott.ssa Barbara Sabiu.

CODICE STRUMENTO DESCRIZIONE

RIUNITO ODONTOIATRICO

PRODUTTORE/FORNITORE ANNODIACQUISTO

TELEFONO

CONTRATTO DI MANUTENZIONE

TIPOLOGIACONTROLLIDAESEGUIRE FREQUENZA

Verifichedisicurezzaelettrica Annuale

Controllo funzionamento Manipoli, aria acqua, lampada Giornaliera

Controllofunzionamentoaspirazione Settimanale

REGISTRAZIONIMANUTENZIONEESEGUITA DATA

CODICE STRUMENTO DESCRIZIONE

STERILIZZATRICE

PRODUTTORE/FORNITORE ANNODIACQUISTO

TELEFONO

CONTRATTO DI MANUTENZIONE

TIPOLOGIACONTROLLIDAESEGUIRE FREQUENZA

Verifichedisicurezzaelettrica Annuale

Controllo Vacuum Test Giornaliero

TestBowieandDick Mensile

REGISTRAZIONIMANUTENZIONEESEGUITA DATA

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 12:

Documentazione tecnica relativa alle singole attrezzature e apparecchiature immediatamente disponibile agli operatori interessati e alla funzione preposta alla manutenzione

Cod. Requisito
1A.03.02.03

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 12

Cod. Requisito 1A.03.02.03 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

DOCUMENTAZIONE TECNICA DELLE ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE

1. Obiettivo

Garantire la disponibilità immediata della documentazione tecnica relativa a tutte le attrezzature e **apparecchiature utilizzate nello studio odontoiatrico, al fine di:**

■ Assicurare l'utilizzo corretto e sicuro da parte degli operatori;
■ Facilitare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
■ Rispettare i requisiti di sicurezza e conformità normativa.

2. Modalità di Gestione della Documentazione

■ Tutta la documentazione tecnica è conservata in formato cartaceo in appositi faldoni e/o digitale in un archivio dedicato ("Manuali Tecnici e Schede Apparecchiature").
■ Copie digitali sono archiviate su server locale o Hard-disk aziendale con accesso riservato al personale autorizzato.
■ **La documentazione deve essere sempre disponibile:**

o Agli operatori sanitari che utilizzano le apparecchiature;
o Alla funzione preposta alla manutenzione (interna o esterna);
o Al Responsabile della Sicurezza o RSPP, se richiesto.

3. Contenuti della Documentazione Tecnica

Per ogni attrezzatura o apparecchiatura sono presenti almeno i seguenti documenti:

Tipo di Documento:

■ Manuale d'uso e manutenzione;
■ Scheda tecnica;
■ Certificato di conformità CE;
■ Registro manutenzioni;
■ Scheda sicurezza materiali;
■ Check-list di controllo periodico
■ Garanzie e contratti di assistenza

4. Aggiornamento e Controllo

■ La documentazione è revisionata annualmente o ad ogni sostituzione di apparecchiatura.
■ Il titolare dello studio verifica la completezza dei fascicoli tecnici.
■ Ogni nuova apparecchiatura sarà registrata prima della messa in servizio.

5. Modalità di Consultazione

■ Gli operatori possono consultare la documentazione tramite terminale informatico o raccoglitore cartaceo posto in segreteria.
■ Gli addetti alla manutenzione dispongono di accesso dedicato ai fascicoli.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 13:

Documentazione tecnica - caratteristiche ambientali e accessibilita

Cod. Requisito
1A.03.05.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 13

Cod. Requisito 1A.03.05.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

In relazione a quanto prescritto dalla norma vigente, si fa presente che:

1. L'attività lavorativa si svolge all'interno di un locale sito a piano terra con ingresso da Via Ammiraglio Gravina 9 – 11.
2. L'immobile in oggetto è censito al N.C.E.U. del Comune di San Giovanni Suergiu al foglio n° 3 particella 3150 sub 9

categoria A/10, per lo stesso è stato rilasciato dal comune di San Giovanni Suergiu:

■ Certificato di destinazione d'uso specifico a studio medico, giusto atto di concessione N° 19 del 31.07.2001, ed autorizzazione N° 04 del 02 marzo 2007 per la fusione ed il cambio della destinazione d'uso del locale.
■ È stata dichiarata agibile dal municipio di San Giovanni Suergiu giusto certificato di agibilità Prot. N°

21435/07 rilasciato in data 17.10.2007.

■ È stata rilasciata dal Comune di San Giovanni Suergiu Autorizzazione allo scarico n° 89 del 17.10.2007;
3. Nello stabile non vi è presenza di piani scantinati e, pertanto non necessita di autorizzazione all'uso dei locali seminterrati, prevista dell'art. 65 D.Lgs 81/08.
4. Non ha bisogno di autorizzazione all'emissione in atmosfera, ai sensi del 203/88, in quanto, non produce vapori e/o emissioni in atmosfera;
5. Non rientra fra quelli cui è necessaria la valutazione d'impatto ambientale;

6. Non necessita di Certificato di Prevenzione Incendi.

7. Non è elencata fra le attività classificate come insalubri, il suo esercizio non reca in ogni modo nocumento alla salute del vicinato.
8. Oggetto della nuova richiesta di autorizzazione è dovuta per il cambio del titolare del locale già adibito a studio medico odontoiatrico,
9. La presente ha lo scopo di segnalare, la modifica degli impianti e delle attrezzature all'interno del locale, adibito sostanzialmente a studio medico odontoiatrico.
10. In relazione al tipo d'attività svolta, e alle lavorazioni che sono effettuate, bene si prestano i locali.

Pertanto visto il certificato di Agibilità Prot. N° 21435/07 rilasciato dal Comune di San Giovanni Suergiu in data 17.10.2007, si attestano i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di caratteristiche ambientali e di accessibilità.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 14:

Documentazione tecnica - protezione antincendio

Cod. Requisito
1A.03.05.02

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 14

Cod. Requisito 1A.03.05.02 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Lo studio ha stipulato un contratto disponibile in sede per la fornitura e la manutenzione ordinaria/straordinaria dei presidi antincendio secondo quanto previsto dal D.M. 03/07/2021 con la ditta ITALFIRE S.R.L.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 15:

Documentazione tecnica - protezione acustica

Cod. Requisito
1A.03.05.03

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 15

Cod. Requisito 1A.03.05.03 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Requisiti in materia di protezione acustica

Il presente documento attesta che lo Studio Odontoiatrico del Dott. Francesco Teresi, sito in San Giovanni Suergiu Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU).

è conforme ai requisiti tecnici e normativi vigenti in materia di protezione acustica relativamente a:

- Isolamento acustico dei locali;
- Livelli di rumorosità interna ed esterna;
- Emissioni sonore delle apparecchiature odontoiatriche e ausiliarie;
- Tutela dei lavoratori esposti a rumore.

Tipologia delle Attività

Lo studio svolge le seguenti attività:

- Prestazioni odontoiatriche e chirurgiche ambulatoriali;
- Attività di igiene e profilassi dentale;
- Sterilizzazione di strumenti e materiali.

Le apparecchiature utilizzate comprendono:

- Riuniti odontoiatrici con aspiratori e micromotori;
- Compressori medicali insonorizzati;
- Autoclavi per sterilizzazione;
- Aspiratori chirurgici.

Pertanto ai sensi del D. Lgs. 81/08, l’attività odontoiatrica non produce emissioni acustiche che possano rientrare oltre ai “Valori inferiori di esposizione che fanno scattare l’azione”

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 16:

Documentazione tecnica - sicurezza elettrica e continuita elettrica

Cod. Requisito
1A.03.05.04

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 16

Cod. Requisito 1A.03.05.04 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

La presente documentazione attesta che lo Studio Sabiu SRL Francesco Teresi, sito in San Giovanni Suergiu Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU).

è dotato di impianti elettrici conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle normative, e da quando è stato redatto il progetto e la dichiarazione di conformità non sono avvenute modifiche.
Pertanto presso la sede dello studio odontoiatrico è disponibile il progetto dell'impianto elettrico

redatto da:

- Professionista abilitato Ing. Antonino Romano;
- Dichiarazione di conformità redatta dall'impiantista GIMAX s.n.c. di Morici G. e Romano M. ai sensi del D.M. 64/08.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 17:

Documentazione tecnica - sicurezza anti-infortunistica

Cod. Requisito
1A.03.05.05

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 17

Cod. Requisito 1A.03.05.05 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Documentazione tecnica sulla sicurezza antinfortunistica

Conformità alle normative di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche).

Questa documentazione serve ad attestare che lo studio:

■ Ha valutato i rischi specifici delle proprie attività (cliniche, radiologiche, di sterilizzazione, ecc.);
■ Ha adottato misure preventive e protettive adeguate;
■ Dispone di dispositivi, impianti e attrezzature conformi;
■ Forma e informa il personale.

Attestazione del possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di sicurezza antinfortunistica

1. Premessa e riferimenti normativi

Studio Odontoiatrico del Dott.ssa Barbara Sabiu, sito in San Giovanni Suergiu via Ammiraglio Gravina 9-11 è conforme alle disposizioni legislative e normative vigenti in materia di sicurezza antinfortunistica e
tutela della salute nei luoghi di lavoro, in particolare:

■ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. – “Testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”;
■ D.M. 10/03/1998 e D.M. 3/09/2021 – Prevenzione incendi e gestione emergenze;
■ D.Lgs. 475/1992 – Dispositivi di protezione individuale (DPI);
■ D.Lgs. 81/2008 – Titolo III (Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI);
■ D.Lgs. 81/2008 – Titolo IX (Agenti chimici e biologici);

2. Obiettivi

Il presente fascicolo ha lo scopo di:

■ Attestare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi previsti per la sicurezza dei lavoratori;
■ Documentare le misure di prevenzione e protezione adottate;
■ Garantire la tracciabilità delle attività di controllo, manutenzione e formazione.

3. Tipologia delle attività svolte

Lo studio odontoiatrico svolge attività di:

■ Diagnosi, terapia e chirurgia odontoiatrica ambulatoriale;
■ Sterilizzazione di strumenti;
■ Igiene orale professionale.

Personale presente:

■ Odontoiatri N° 1

4. Requisiti e misure antinfortunistiche adottate

Area / Rischio Misure adottate Documentazione Esito
disponibile
Rischi generali nei luoghi Conformità locali, DVR, planimetrie Conforme
di lavoro illuminazione, aerazione, ■
segnaletica di sicurezza
Attrezzature Conformità CE, uso secondo Manuali, schede tecniche, Conforme
odontoiatriche e di manuali, controlli periodici registro manutenzioni ■
sterilizzazione
Impianto elettrico e Verifica impianto, messa a Certificato di conformità Conforme
sicurezza elettrica terra, differenziali, ■

Rischio biologico DPI, procedure di DVR, protocolli, registro Conforme
sterilizzazione, raccolta rifiuti sterilizzazioni ■
sanitari
Rischio chimico Valutazione rischio chimico, Schede di sicurezza, DVR Conforme
(disinfettanti, monomeri, etichette CLP, SDS ■
anestetici)

Antincendio e emergenze Estintori, vie di fuga, piano Registro controlli Conforme
emergenza, prove evacuazione antincendio, planimetrie ■
Formazione e Formazione generale, Attestati corsi, registro Conforme
informazione specifica e primo soccorso formazione ■
Sorveglianza sanitaria Visite mediche periodiche e Cartelle sanitarie, nomina Conforme
idoneità medico competente ■

5. Documentazione tecnica disponibile presso lo studio

1. Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

2. Piano di emergenza e gestione incendi;

3. Registro controlli antincendio e primo soccorso;

4. Manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature;

5. Certificati CE e dichiarazioni di conformità;

6. Schede di sicurezza (SDS) dei prodotti chimici;

7. Verbali di verifica impianto elettrico e di terra;

8. Registro formazione e addestramento;

9. Relazioni tecniche su sicurezza elettrica;

10. Contratti di manutenzione periodica.

6. Controllo e aggiornamento

■ La documentazione è verificata e aggiornata annualmente dal Responsabile della Sicurezza
o RSPP;
■ Tutte le attrezzature sono sottoposte a manutenzione preventiva programmata;
■ Eventuali nuovi rischi introdotti da modifiche strutturali o tecnologiche vengono valutati e
integrati nel DVR.

7. Descrizione dei locali

I pavimenti sono stati realizzati in gres porcellanato e consentono la perfetta pulizia non vi sono
fessure che sono ricettacolo di batteri e sporcizia, con classe di resistenza allo scivolamento R9.
Non sono presenti dislivelli, gradini o pendenze.
Dal punto di vista costruttivo, la struttura dell'edificio è realizzata con travi e pilastri in cemento
armato.
I tompagnamenti perimetrali sono in blocchi di tufo e hanno uno spessore finito di circa30 cm.
Itramezzi sono realizzati in parte con pannelli di faesite facili da pulire, in parte in conci di tufo,
ehanno uno spessorefinito di 0.15 cm
Le finiture delle pareti sono realizzate con pittura ad acqua lavabile antimuffa, e le pareti del bagno
sono ricoperte di piastrelle sino ad una altezza di 2,20 mt
Le scaffalature ed i pensili sono correttamente ancorati alle pareti.
Gliarredi sonoprividispigolivivi.
Ladistanzatradiessi consenteiltransitodel personale a congrua distanza, circostanza che minimizza la
probabilità di urti con gli stessi.

8. Allegati (esempi)

■ Allegato – Copia DVR aggiornato
■ Allegato – Schede DPI e protocolli operativi di sicurezza
■ Allegato – Attestati formazione personale
■ Allegato – Verbali manutenzione impianti e attrezzature

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 18:

Documentazione tecnica - protezione da radiazioni ionizzanti

Cod. Requisito
1A.03.05.06

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 18

Cod. Requisito 1A.03.05.06 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Il titolare dello Studio Sabiu SRL Francesco Teresi, sito in San Giovanni Suergiu Via Ammiraglio Gravina n. 9 -11_Piano Terra.

Dichiara

Che all’interno dello studio non vi sono apparecchiature che producono radiazioni ionizzanti.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 19:

Documentazione tecnica - eliminazione barriere architettoniche

Cod. Requisito
1A.03.05.07

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 19

Cod. Requisito 1A.03.05.07 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

DICHIARAZIONE TECNICA DI CONFORMITÀ AI REQUISITI DI ACCESSIBILITÀ

(ai sensi della L. 13/1989, D.M. 236/1989 e s.m.i.)

Il titolare dello Studio Sabiu SRL Francesco Teresi, sito in San Giovanni Suergiu Via Ammiraglio Gravina n. 9 -11_Piano Terra.

Dichiara

Di aver verificato la conformità dell'immobile in oggetto alle normative vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e del D.P.R. 503/1996, nonché alle norme regionali e comunali vigenti.

Descrizione dell'immobile e dell'accesso

L'attività odontoiatrica è ubicata al piano terra di un edificio, con accesso diretto dalla pubblica via mediante ingresso privo di barriere architettoniche.

■ Percorso esterno: il marciapiede antistante presenta una pavimentazione regolare e priva di dislivelli superiori a 2,5 cm.
■ Accesso principale: dotato di porta con luce netta ≥ 90 cm.

In base ai rilievi effettuati e alla documentazione tecnica visionata, si attesta che lo studio odontoiatrico sito al piano terra in San Giovanni Suergiu Via Don Minzoni 20 risulta conforme alle prescrizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, garantendo l'accessibilità, la visitabilità e l'adattabilità previsti dalla normativa.

Inoltre trattandosi di uno studio privato di odontoiatria non si è soggetti alle prescrizioni della normativa vigente.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 20:

Documentazione tecnica - smaltimento dei rifiuti

Cod. Requisito
1A.03.05.08

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 20

Cod. Requisito 1A.03.05.08 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Il titolare dello Studio Sabiu SRL Francesco Teresi, sito in San Giovanni Suergiu Via Ammiraglio Gravina n. 9 -11_Piano Terra.

Dichiara

Di aver stipulato un contratto con la ditta Ambietal S.r.l. via Pingitore n. 2 – 90017 Santa Flavia (PA) P.IVA: 03477990828 specializzata per il ritiro e lo smaltimento deirifiuti speciali.

Il presente contratto allegato alla presente e anche disponibile in sede.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 21:

Documentazione tecnica - condizioni microclimatiche

Cod. Requisito
1A.03.05.09

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 21

Cod. Requisito 1A.03.05.09 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

DICHIARAZIONE TECNICA DI CONFORMITÀ – CONDIZIONI MICROCLIMATICHE

(ai sensi del D.Lgs. 81/2008, D.P.R. 74/2013, UNI EN ISO 7730 e s.m.i.)

1. Dati generali

Oggetto: Studio odontoiatrico – Verifica condizioni microclimatiche
Comune: San Giovanni Suergiu (PA)
Ubicazione: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU).
Titolare attività: Dott. Francesco Teresi

2. Premessa

Per gli adeguamenti delle condizioni ambientali e impiantistiche, il Dott. Tereso Francesco per garantire la conformità dei locali adibiti a studio odontoiatrico alle vigenti disposizioni in materia di microclima e benessere termico, ha predispostounimpianto di climatizzazionea pompe di calorea semplice split dotate discaricodicondensaadeguatamentecanalizzata, ed inoltre a istallato un impianto di ricambio d'aria e ventilazione meccanica controllata.

Gli stessi consentono il mantenimento di temperature e percentuali di umidità ottimali nei mesi estivi ed invernali.

La pulizia e sanificazione dei filtri è prevista con cadenza trimestrale.

4. Descrizione dell'immobile e degli impianti

Lo studio odontoiatrico è situato al piano terra, dotato di:

■ Impianto di climatizzazione estiva/invernale con distribuzione a espansione diretta e regolazione della temperatura per ambiente;
■ Impianto di ricambio d'aria e ventilazione meccanica controllata

è stato istallato un recuperatore di calore "Mitsubishi Electric" denominato "Lossnay" modello LGH-50RX5 avente una portata d'aria mc/h 500 (S.Alta) a 150 Pa e di mc/h 350 (bassa) a 30 Pa. Garantendo una portata d'aria ≥ 6 vol/h nei locali operativi e ≥ 3 vol/h nei locali di attesa; (si allega scheda tecnica dell'istallatore)

■ filtrazione aria conforme alla classe minima F7 (UNI EN ISO 16890) per ambienti sanitari;
■ sistemi di regolazione e manutenzione programmata documentata nel libretto d'impianto;
■ umidità relativa mantenuta tra 40% e 60%;
■ temperatura operativa media tra 20–24 °C in inverno e 24–26 °C in estate.

5. Valutazione delle condizioni microclimatiche

Sulla base delle misurazioni e della documentazione tecnica degli impianti, si riscontra che:

■ i valori di temperatura, umidità relativa, velocità dell'aria e tasso di ventilazione rientrano nei limiti raccomandati per ambienti sanitari;

■ i locali destinati a sala d'attesa, ambulatori odontoiatrici, locale sterilizzazione e servizi igienici garantiscono un microclima idoneo al comfort termico e alla sicurezza igienico-sanitaria;
■ l'impianto è oggetto di manutenzione periodica e controlli di efficienza energetica.

6. Conclusioni

Pertanto lo studio odontoiatrico in oggettopossiede i requisiti microclimatici previsti dalle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti, garantendo adeguate condizioni di aerazione e di comfort ambientale.

Allegati

■ Scheda tecnica impianto di climatizzazione e recuperatore d'aria;
■ Verbale ultima manutenzione e controllo efficienza energetica;
■ Planimetria dei locali con indicazione dei punti di aerazione;

SCHEDAREGISTROMANUTENZIONEIMPIANTODICONDIZIONAMENTO

INTERVENTO

POSIZIONE DATA OPERATORE NOTE

(Indicaregliinterventieffettuati)

SALA ATTESA

SEGRETERIA

SALA OPERATIVA 1

SALA OPERATIVA 2

SALA PERSONALE

SALA

STERILIZZAZIONE

Intervento:

1) Rimozione filtro
2) Aspirazione polveri
3) Sgrassaggio
4) Sterilizzazione/Disinfezione/Sanificazione (per immersione almeno 30 mini soluzione, o in alternativa trattamento con spray specifico)
5) Posizionamento filtro
6) Sostituzione filtro
7) Prodotto utilizzato: _____

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 22:

Documentazione tecnica - impianti di distribuzione dei gas

Cod. Requisito
1A.03.05.10

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 22

Cod. Requisito 1A.03.05.10 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Il titolare dello Studio Sabiu SRL Francesco Teresi, sito in San Giovanni Suergiu Via Ammiraglio Gravina n. 9 -11_Piano Terra.

Dichiara

Che all’interno dello studio non vi sono presenti impianti di distribuzione di gas.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 23:

Documentazione tecnica - materiali esplodenti

Cod. Requisito
1A.03.05.11

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 23

Cod. Requisito 1A.03.05.11 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Il titolare dello Studio Sabiu SRL Francesco Teresi, sito in San Giovanni Suergiu Via Ammiraglio Gravina n. 9 -11_Piano Terra.

Dichiara

Che all’interno dello studio non sono presenti materiali esplodenti.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 24:

Documentazione tecnica - protezione antisismica

Cod. Requisito
1A.03.05.12

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 24

Cod. Requisito 1A.03.05.12 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

L'immobile sito in San Giovanni Suergiu Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU) adibito a studio odontoiatrico è stato dichiarato agibile dal municipio di San Giovanni Suergiu giusto certificato di agibilità Prot. N° 21435/07 rilasciato in data 17.10.2007.
Da tale data l'immobile non ha subito variazioni strutturali tali da richiedere un nuovo nulla osta strutturale.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 25:

Obblighi assicurativi definiti dalla normativa applicabile

Cod. Requisito
1A.04.12.04

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 25

Cod. 1A.04.12.04 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL | Responsabile: Dott.ssa Barbara Sabiu | Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)

Documento da compilare a cura del Responsabile della struttura.

Data: 29/03/2026 Firma: _____

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 26:

Carta dei servizi

Cod. Requisito
1A.05.03.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 26

Cod. Requisito 1A.05.03.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

CARTA DEI SERVIZI

STUDIO

ODONTOIATRICODOTT.TE

RESI FRANCESCO

Via Ammiraglio
Gravina n°9– 11

Rev.01del03/11/2025 Pag.1di11

INDICE

1. Studio Sabiu SRLssa Barbara Sabiu

1.1 Presentazione

1.2 Fini istituzionali

1.3 Principi fondamentali

2. PRESTAZIONI, MODALITA'DIACCESSO, STANDARD

2.1 Prenotazione eaccettazione

3. TUTELA DEGLI UTENTI E CONTROLLI DELLA QUALITA'

3.1 Organismi di controllo e verifica

3.2 Rilevazione della soddisfazione degli utenti

3.3 Gestione dei Reclami

Rev.01del03/11/2025 Pag.2di11

Gentile utente,

La presente Carta dei Servizi è essenzialmente volta alla tutela dei diritti degli utenti del nostro Studio e costituisce un importante strumento di controllo da parte del cittadino sulle modalità di erogazione dei servizi offerti, sugli standard di qualità garantiti e sulla completezza delle informazioni fornite.

Essa illustra, inoltre, gli organismi interni preposti alla tutela dell'utente e le procedure per la presentazione dei reclami relativi ad atti o comportamenti che possano limitare o impedire la piena fruibilità delle prestazioni sanitarie. In tal modo, lo Studio assicura la trasparenza, la correttezza e l'efficacia delle prestazioni offerte.

Ai cittadini utenti è richiesto di collaborare attivamente, anche attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione, al fine di consentire un continuo miglioramento della qualità del servizio, frutto dell'impegno condiviso e coordinato di tutto il personale operante nello Studio.

In sintesi, l'obiettivo che ci proponiamo è quello di coinvolgere direttamente il cittadino utente nella gestione della propria salute, promuovendo la conoscenza, la libera scelta e la verifica dei servizi offerti.

IlTitolare

Rev.01del03/11/2025 Pag.3di11

1. Lo Studio Sabiu SRLssa Barbara Sabiu

1.1 PRESENTAZIONE

La struttura sanitaria in oggetto è un riferimento d'eccellenza per il territorio nelcampo odontoiatrico, ed offre una gamma di servizi che si erogano in ambienti dimoderna concezione in cui sono previstedue sale operative dotate di attrezzature di nuova concezione tecnologica, soluzioni impiantistiche all'avanguardia, ed è situata in una zona facilmente raggiungibile.

L'esecuzione delle prestazioni vanno dalla diagnosi alla cura e si inoltrano nelle seguenti **branche specialistiche della scienza e dell'arte odontoiatrica:**

1) Odontoiatria Conservativa e Restaurativa
2) ChirurgiaOrale
3) Protesi dentaria riabilitativa e funzionale
4) Ortodonzia fissa, mobile, e funzionale
5) Igieneorale
6) Implantologia
7) Endodonzia

Lo studio odontoiatrico considera obiettivo primario il conseguimento di una qualità ottimale delle prestazioni fornite ai pazienti. Questo obiettivo impegnatutto il personale ad adeguare il proprio sistema operativo ed organizzativo alle richieste e ai bisogni dell'utenza.
L'alta professionalità degli operatori garantisce una totale sicurezza e fiducia sia nelle prestazioni e sia nella fase di accettazione e contatti con la clientela.

ORARI DI APERTURA:

■ Lunedì Giovedì 9.00 – 12.30

14.30- 19.00

■ Venerdì 9.00 – 12.00

Ragione sociale: Studio Odontoiatrico Privato.
Denominazione: Studio Sabiu SRLssa Barbara Sabiu
Sede: Via Ammiraglio Gravina 9 -11
Tel: 3392900330
Email: teresifrancesco@outlook.it
Azienda di appartenenza: ASP6 - Palermo

Rev.01del03/11/2025 Pag.4di11

1.2 INFORMAZIONI PER L'UTENTE

COME ARRIVARE

Lo Studio Odontoiatrico è situato in San Giovanni Suergiu Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU).
■ E' raggiungibile tramite mezzi pubblici (autobus di linea) con fermata a me t r i 50 dallo Studio o con il Taxi
■ Con mezzi privati che trovano facilmente parcheggio in zona: (foto Google)

Rev.01del03/11/2025 Pag.5di11

1.2 FINI ISTITUZIONALI

Scopo dello Studio è quello di erogare prestazioni odontoiatriche connesse con le esigenze dei cittadini; Lo Studio intende, inoltre, partecipare attivamente alla integrazione delle attività di quanti operano nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale (medici di **base, medici specialisti, strutture ospedaliere, etc.). I suoi fini istituzionali sono:**

■ Facilitare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini, riducendo al minimo i tempi di attesa e semplificando le procedure.
■ Ricercare ed attuare il massimo della sicurezza e dell'efficienza nell'esecuzione delle procedure odontoiatriche e nell'assistenza agli utenti.
■ Garantire prestazioni del più alto livello di qualità, rispondenti alle esigenze di personalizzazione delle attività sanitarie.
■ Garantire la disponibilità di tutti i mezzi giudicati necessari da parte dell'équipe di medici, biologi e tecnici che operano al suo interno.
■ Informare compiutamente e correttamente il cittadino sull'iter successivo all'esecuzione degli esami e alla presentazione dei risultati.
■ Partecipare alla ricerca scientifica nel settore, favorendo l'attività multidisciplinare e la collaborazione con centri, enti e istituzioni esterne.
■ Partecipare alla formazione di odontoiatri, tecnici e personale amministrativo.

1.3 PRINCIPI FONDAMENTALI

Eguaglianza
Lo Studio si impegna costantemente per assicurare l'accesso ai propri servizi nei tempi più brevi possibili, qualunque sia l'appartenenza sociale, razziale, ideologica, politica, economica e di età del cittadino utente in ossequio ai principi fondamentali di eguaglianza.
Imparzialità
Il personale del Centro ispira il proprio comportamento a criteri di giustizia e imparzialità nel pieno rispetto dei principi della dignità umana.
Efficienza ed efficacia
L'efficienza dell'organizzazione e l'efficacia delle prestazioni sono i due principi ispiratori dell'attività dello Studio.
Partecipazione
Lo Studio assicura al cittadino, nelle forme previste dalla legge, la possibilità diaccedere alle informazioni riferite alla propria persona, delle quali può richiederecopiain qualsiasi momento, e di formulare proposte di soluzioni migliorativenell'erogazionedeiservizi.

Rev.01del03/11/2025 Pag.6di11

2. ORGANIZZAZIONE

■ Si tratta di un'organizzazione molto semplice, dal momento che la Direzione accentra la maggior parte delle attività critiche dell'ambulatorio.
■ Il seguente organigramma illustra nel dettaglio le figure professionali presenti.

Titolare
Dott. TERESI
FRANCESCO

EspertoQualificato

_____

SEGRETERIA/URP

RESP. MANUTENZIONE

Dott. AMMINISTRAZIONE Dott.TERESI
Dott.TERESI FRANCESCO
RESP. FRANCESCO

SISTEMAQUALIT

A' ODONTOIATRIA

Dott. Dott.TERESI
TERESI FRANCESCO

FRANCESCO

Rev.01del03/11/2025 Pag.7di11

3. PRESTAZIONI, MODALITA' DI ACCESSO, STANDARD

Le prestazione offerte dal Centro odontoiatrico sono le seguenti:

■ Visitaodontoiatrica
■ Endodonzia
■ Conservativa
■ Estrattiva
■ Parodontologia/implantologia
■ Ortodonzia
■ Protesi

Presso la segreteria dello Studio è disponibile un prontuario dettagliato delle singole prestazioni. Il cliente può fare espressa richiesta di prendere in visione tale elenco, al personale di segreteria.

3.1 Prenotazione e accettazione

Modalità di Accesso e Gestione delle Prestazioni

L'utente può richiedere l'effettuazione di una visita:

■ Telefonando negli orari di apertura riportati nel frontespizio;
■ Presentandosi direttamente al Centro in qualunque giorno feriale.

In quest'ultimo caso, vengono rispettati i turni in base all'ordine di arrivo e alla priorità delle emergenze.
I piani di cura vengono preventivamente concordati con il medico e regolarmente registrati.

Gestione delle Emergenze

Le emergenze sono gestite secondo le seguenti modalità:

■ Emergenza urgente (emorragia, dente fratturato, dolore spontaneo intenso, gonfiore con **rialzo termico, decementazione provvisoria con dolore):**

→ Appuntamento immediato con il medico responsabile, senza tener conto dell'ordine delle prenotazioni.

■ **Emergenza (rottura di protesi, frattura di dente non dolente):**

→ Appuntamento entro 24 ore con il medico responsabile.
■ Urgenza (rottura di protesi senza impedimenti particolari, caduta di otturazione senza **dolore, decementazione, rottura o danno ortodontico):**

→ Appuntamento entro 48-72 ore con il medico responsabile.

Comunicazioni e Documentazione

■ Le chiusure programmate dello studio sono comunicate per tempo mediante affissione.
Rev. 01 del 01/01/2026 Pag.8di11

■ Le chiusure per cause di forza maggiore saranno tempestivamente comunicate agli utenti.
■ Il paziente deve essere provvisto di un documento di riconoscimento, come richiesto dalle normative sanitarie nazionali e regionali in materia di privacy.
■ Il paziente è tenuto a fornire tutte le informazioni relative al proprio stato di salute e alle eventuali terapie in corso, per consentire una diagnosi e una cura accurate.
■ Il mancato rispetto di uno o più appuntamenti, se non concordato con il personale di studio, autorizza il Titolare a considerare chiuso il piano di cura.

Consenso Informato e Trattamento dei Dati

L'utente deve inoltre sottoscrivere il modulo di consenso informato per il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 101/2018.

Tempi di Attesa

Per quanto riguarda i tempi medi di attesa, si fa riferimento al tempo necessario per sottoporsi alla visita iniziale, che viene erogata al momento stesso della richiesta.
Il tempo successivo per le altre prestazioni è stabilito in base alla tipologia dell'intervento e alle esigenze del paziente, e pertanto non è standardizzabile.

Prenotazioni e Gestione delle Liste d'Attesa

La segreteria dello studio Studio Sabiu SRL può ricevere prenotazioni:

■ Telefonicamente (chiamate, SMS, WhatsApp, e-mail);
■ Direttamente in studio, preferibilmente previo appuntamento telefonico.

Le liste d'attesa sono gestite dal personale preposto tramite un software gestionale o, in alternativa, mediante agenda cartacea, tenendo conto delle urgenze e delle terapie di particolare impegno stabilite dal Titolare.

■ Al paziente presente fisicamente viene consegnata una ricevuta di promemoria;
■ Al paziente non presente viene inviato un SMS di conferma e promemoria.

Modalità di Pagamento

Il pagamento delle prestazioni prevede:

■ Un acconto iniziale pari a circa il 30% dell'importo totale, dopo l'accettazione del preventivo del piano di cura;
■ Un secondo acconto durante l'erogazione delle prestazioni;
■ Il saldo finale alla conclusione del trattamento.

Le modalità di pagamento possono essere scelte dal cliente tra le opzioni proposte dallo studio.

■ Contante (massimale secondo le norme di legge vigenti)
Rev. 01 del 01/01/2026 Pag.9di11

■ Bonifico bancario
■ **POS**
■ Finanziamento

STANDARD

INURGENZA INELEZIONE

TEMPID'ATTESA IMMEDIATA 3GIORNILAVORATIVI

PERVISITA

ODONTOIATRICA

TEMPID'ATTESA PER TRATTAMENTO 3GIORNI 7GG

TEMPID'ATTESA PER IMPLANTOLOGIA 14GG

TEMPID'ATTESA PER ORTODONZIA 14GG

Indicatori, valori di accettabilità e metodi di verifica dei requisiti

Valore di
Indicatore Metodo di verifica
accettabilità

Verifica accuratezza dei controlli sulla Verifica attività a campione (5
100%
sterilizzazione attività ogni mese)

Verifica rispetto dei protocolli 100% Riesame annuale dei protocolli

Rilevazione a campione su almeno
Verifica della completezza dei referti rilasciati
100% 10 cartelle o referti ogni 4 mesi

Verifica registrazioni avvenuto controllo su Rilevazione a campione su apparecchiature/ impianti/dispositivi/farmaci 100% almeno 10 registrazioni dei controlli ogni 6 mesi

4.TUTELA DEGLI UTENTI E CONTROLLI DELLA QUALITÀ

4.1 ORGANISMIDICONTROLLOEVERIFICA

Lo Studio tramite il suo Titolare garantisce la supervisione ed il controllo di tutte le attività svolte al proprio interno, sia nell'ambito strettamente sanitario, sia in quello tecnologico.
Lo stesso inoltre

• Garantisce l'informazione, l'accoglienza e la tutela degli utenti, con particolare riguardo agli aspetti di personalizzazione e umanizzazione del rapporto.
• Analizza le risultanze dei reclami pervenuti e i dati dei questionari di soddisfazione compilati dai cittadini utenti.
• Promuove l'attuazione delle azioni correttive e preventive necessarie al superamento delle criticità riscontrate.
• Riesamina annualmente l'intera struttura per assicurare la costante adeguatezza dei servizi rispetto alle aspettative dei cittadini utenti.

Rev. 01 del 01/01/2026 Pag.10di11

• Garantisce il rispetto del "Codice deontologico della professione dei medici chirurghi e degli odontoiatri", aggiornato il 16 dicembre 2006 dalla FNOMCeO (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri), nonché delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia di esercizio delle attività odontoiatriche.

4.2 RILEVAZIONE DELLA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Lo Studio rileva periodicamente il grado di soddisfazione e i motivi di eventuale insoddisfazione degli utenti che hanno usufruito dei propri servizi, mediante la distribuzione di un questionario anonimo. I risultati della rilevazione vengono sintetizzati in un report trimestrale, che rappresenta un importante punto di riferimento per il miglioramento continuo del servizio.

4.3 GESTIONE DEI RECLAMI

La presentazione di un reclamo da parte di un cittadino utente rappresenta un segnale

importante della possibile esistenza, all'interno del sistema organizzativo, di disfunzioni che possono avere origine nell'organizzazione stessa, nella struttura tecnica dei servizi o nei comportamenti del personale.

Ai fini del mantenimento dei più alti livelli di qualità del servizio, che costituisce l'obiettivo strategico dello Studio, tale segnalazione è di fondamentale importanza, in quanto consente di intervenire tempestivamente per l'eliminazione delle disfunzioni e per il ripristino degli standard qualitativi.

Il reclamo viene quindi considerato come un contributo collaborativo da parte dei cittadini utenti al miglioramento del sistema aziendale e, come tale, è oggetto della massima attenzione.

Lo Studio si impegna a instaurare con chi ha presentato il reclamo un rapporto trasparente e collaborativo, volto alla risoluzione del problema e alla prevenzione di eventuali recidive.

Lo Studio si è dotato di una procedura formalizzata per la gestione dei reclami, che mira non soltanto alla risoluzione delle problematiche segnalate, ma anche a costituire un'importante fonte di informazione di ritorno sull'efficacia e l'efficienza del proprio sistema di qualità.

Modalità di Presentazione dei Reclami

I cittadini utenti possono presentare eventuali reclami relativi a disservizi riscontrati prima, durante o dopo l'erogazione delle prestazioni da parte dello Studio, con le **seguenti modalità:**

- Per iscritto, utilizzando l'apposito modulo predisposto, disponibile presso l'ufficio di accettazione;
- Per iscritto su carta semplice o tramite posta elettronica (e-mail);
- Verbalmente, rivolgendosi al personale in servizio presso lo Studio.

Rev. 01 del 01/01/2026 Pag.11di11

Raccolta dei Reclami e delle Osservazioni

Presso la segreteria dello Studio è presente una cassetta appositamente predisposta, all'interno della quale l'utente può depositare i moduli di reclamo e, più in generale, qualsiasi osservazione o suggerimento finalizzato al miglioramento degli standard di qualità dei servizi erogati.

Il Titolare dello Studio si impegna a fornire una risposta a tutti i reclami entro il termine massimo di 8 giorni dalla loro ricezione.

Disponibilità della Carta dei Servizi

Una copia della Carta dei Servizi è disponibile nella sala d'attesa e presso la segreteria dello Studio, a disposizione degli utenti e del personale.

Revisione del Documento

La revisione del presente documento è prevista con cadenza annuale e, in ogni caso, a **seguito di modifiche riguardanti:**

- Le modalità e tipologie di erogazione dei servizi, oppure
- L'organigramma dello Studio.

IL TITOLARE

Rev. 01 del 01/01/2026 Pag.12di11

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 27:

Modalita identificazione di tirocinanti, specializzandi e altri soggetti che intervengono nel percorso assistenziale.

Cod. Requisito
1A.05.03.03

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 27

Cod. 1A.05.03.03 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL | Responsabile: Dott.ssa Barbara Sabiu | Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)

Documento da compilare a cura del Responsabile della struttura.

Data: 29/03/2026 Firma: _____

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 28:

Report criticita riscontrate dall'analisi dei reclami e dei risultati delle indagini di customer satisfaction e relativi Piani di intervento

Cod. Requisito
1A.05.03.05

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 28

Cod. Requisito 1A.05.03.05 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

La presentazione di un reclamo da parte di un cittadino che ha utilizzato i servizi dello studio è un segnale sulla possibile esistenza nel sistema aziendale di disfunzioni che possono avere la loro causa nell'organizzazione, nella struttura tecnica dei servizi, nei comportamenti del Personale. Tale segnale è per noi di importanza fondamentale perché consente di intervenire per la eliminazione delle disfunzioni e di riportare ai livelli la qualità dei servizi. (Customer satisfaction)

Si considera, quindi, il reclamo come un importante apporto collaborativo da parte dei cittadini utenti per il miglioramento del sistema azienda e come tale lo si tratta, dedicandovi la massima attenzione ed instaurando con che ha avuto motivo di reclamare un rapporto di ampia e trasparente collaborazione.

Lo studio si è dotato di una procedura formalizzata per la trattazione dei reclami che mira non soltanto alla risoluzione del problema posto in evidenza ma anche ad agire come importante informazione di ritorno sull'efficacia ed efficienza del sistema qualità dell'azienda.

I cittadini utenti possono presentare eventuali reclami per disservizi subiti prima, durante e dopo l'esecuzione delle prestazioni erogate dal Centro; il reclamo può essere inoltrato con le seguenti **modalità:**

- per iscritto, utilizzando il modulo predisposto disponibile presso l'ufficio di accettazione.
- per iscritto su carta semplice o a mezzo mail.
- verbalmente rivolgendosi al Personale in servizio presso lo studio.

Presso la segreteria dello Studio è presente una cassetta appositamente predisposta all'interno della quale l'utente conferirà i moduli di reclamo e comunque qualunque osservazione volta al miglioramento degli standard di qualità.

La Direzione fornirà una risposta a tutti i reclami entro il termine massimo di 8 giorni.

Scheda fornita ai clienti al fine di utilizzare le loro valutazioni insieme a **quella dei familiari per la progettazione di piani di miglioramento:**

Gentile Signora/Gentile Signore
Il questionario a cui Lei, se vorrà, potrà rispondere è formulato in forma anonima con lo scopo di conoscere il grado di soddisfazione per le prestazioni e i servizi erogati da questo studio. Le Sue risposte e gli eventuali suggerimenti serviranno a migliorare il livello delle prestazioni e dei servizi. È sufficiente che sbarri con una croce la risposta che ritiene più giusta.

1. Come valuta l'ubicazione dell'ambulatorio per facilità di accesso, raggiungimento, e presenza di ostacoli?
Buona Sufficiente Insufficiente Scarsa

2. Come giudica il sistema di prenotazione?

Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

3. Come giudica il sistema di accoglienza?

Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

4. Come giudica il sistema di accettazione?

Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

5. Come giudica la prestazione sanitaria?

Buona Sufficiente Insufficiente Scarsa

6. Come valuta la disponibilità del front office e l'atteggiamento mostrato nel venire incontro alle sue esigenze?
Buona Sufficiente Insufficiente Scarsa

7. Come valuta nel suo insieme tutto il percorso dalla richiesta del suo medico all'esecuzione della prestazione?
Buono Sufficiente Insufficiente Scarso

Qualora avesse dei suggerimenti da proporre, La invitiamo a scriverle nello spazio sottostante.

Grazie per la collaborazione

LA DIREZIONE

P. S. Dopo aver debitamente compilato questo stampato, affinché il tutto avvenga in modo anonimo, La invitiamo a depositarlo presso la segreteria in apposito contenitore.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 29:

Piano aziendale per la gestione del rischio

Cod. Requisito
1A.06.02.01

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 29

Cod. Requisito 1A.06.02.01 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

PIANOAZIENDALEPERLAGESTIONEDELRISCHIO

REV. 01 del 01/01/2026

1. Assistente alla poltrona

In tale gruppo sono compresi gli addetti alle operazioni di supporto all'attività professionale dell'odontoiatra svolta presso lo Studio. Essi operano in prossimità del paziente durante le sedute e si occupano delle esigenze logistiche, quali la preparazione delle attrezzature, le operazioni di sterilizzazione dello strumentario e la disinfezione delle postazioni di lavoro tra un paziente e il successivo.

Descrizione del pericolo Durata Gravità Evento I/R
Disturbi muscolo-scheletrici dovuti a posizioni di
4 2 2 16
lavoro prolungate in piedi o incongrue/inadeguate.
Elettrocuzione durante l'uso di attrezzature elettriche. 2 4 1 8
Infortuni dovuti all'uso di attrezzature manuali, in
particolare a carico degli arti superiori, causati dal 2 2 2 8
contatto con parti taglienti o aghi.
Contatto con materiale organico potenzialmente
2 4 2 16
infetto (ad esempio sangue o saliva).
Rischio biologico: contagio con i ceppi virali HSV1 e
HSV2 HBV e HCV, HIV, batteri e virus responsabili
delle infezioni delle vie aeree superiori, agenti eziologici 2 4 2 16
di affezioni polmonari virali e batteriche (es. legionella)

Inalazione di polveri e vapori/aerosol 3 3 1 9
Irritazioni cutanee dovute all'uso di guanti in lattice. 2 2 1 4
Stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro
3 3 1 9
eccessivi.
"Contatto con detergenti e disinfettanti utilizzati per
3 2 2 12
la manutenzione igienica dei locali e delle
attrezzature."
Rischio da R.I.. 1 4 1 4
Uso dei video terminali 2 1 3 6
Movimentazione manuale dei carichi 1 2 2 4
Ustioni da contatto durante i cicli di sterilizzazione. 2 3 2 12
Microclima 4 2 1 8
Incendio 1 4 1 4
Radiazioni ottiche artificiali (noncoerenti) 2 2 2 8

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Misure di Prevenzione e Protezione Generali

■ Sostituire, ove possibile, i prodotti maggiormente nocivi con altri a minore impatto sulla salute e sull'ambiente.
■ Effettuare ricambi d'aria dei locali in numero adeguato, garantendo una corretta ventilazione.
■ Prevedere un'etichettatura idonea per tutte le sostanze chimiche o tossiche presenti nello studio.
■ Sono predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione elettrica sia all'intero impianto (sul quadro generale) sia alle singole zone operative (quadri di zona).
■ Gli utensili elettrici portatili devono essere corredati da libretto d'uso e manutenzione.

Uso di Prodotti Chimici e Disinfettanti

■ Fornire formazione e informazione ai lavoratori sui rischi connessi all'uso di disinfettanti e prodotti chimici impiegati in odontoiatria.
■ Durante l'uso di tali sostanze, adottare gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con pelle, occhi e altre parti del corpo.

■ Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI).
■ Ogni sostanza deve essere conservata in modo appropriato, secondo le indicazioni riportate nella scheda di sicurezza.
■ È vietato consumare cibi e bevande durante l'utilizzo di sostanze chimiche o disinfettanti.
■ Acquisire e conservare le schede di sicurezza (SDS) relative a tutte le sostanze chimiche e tossiche utilizzate.
■ Predisporre tabelle di pronto soccorso con indicazioni sugli interventi da attuare in caso di esposizione accidentale.

Misure Ergonomiche e Organizzative

■ Attuare misure tecnico-organizzative per ridurre la ripetitività e la monotonia delle operazioni (pause, rotazione delle mansioni, turni equilibrati).
■ Durante le operazioni di pulizia tra un paziente e l'altro, utilizzare sostanze il meno tossiche e volatili possibile.
■ Scegliere prodotti detergenti con pH vicino alla neutralità.
■ Utilizzare e conservare con cura le attrezzature taglienti.
■ Adottare posizioni di lavoro comode ed ergonomiche.
■ I pavimenti devono essere non scivolosi e mantenuti puliti.
■ Le attività di pulizia non devono essere effettuate contemporaneamente ad altre attività operative.
■ L'apertura delle porte non deve generare situazioni di pericolo; devono essere libere da ostacoli, avere maniglie prive di spigoli vivi ed essere facilmente accessibili.
■ L'impianto idraulico deve fornire acqua calda e fredda; devono essere disponibili detergenti e mezzi per l'asciugatura delle mani.
■ I locali devono essere mantenuti in perfette condizioni igieniche.
■ Curare una scrupolosa igiene personale, con lavaggio frequente delle mani.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

I lavoratori devono utilizzare DPI conformi alla normativa CE, in particolare:

■ Guanti in lattice (per operazioni con contatto con liquidi biologici del paziente, es. sangue, saliva, sudore).
■ Indumenti protettivi adeguati (camici o divise sanitarie).
■ Mascherina di protezione delle vie respiratorie, da sostituire indicativamente ogni ora o quando necessario.
■ Visiera protettiva durante le operazioni a stretto contatto con il paziente, soprattutto in caso di utilizzo di strumentazione rotante ad alta velocità.
■ Cuffia per capelli per evitare contaminazioni.
■ Occhiali protettivi durante l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali non coerenti (ROA non coerenti).

2. Collaboratore Odontoiatra/Igienista

In tale gruppo sono considerati i collaboratori di supporto delle attività e pratiche professionali specifiche svolte in regime di consulenza svolte presso lo Studio. Operano in prossimità del paziente durante le sedutee provvedono alla prestazione delle pratiche professionali per le quali sono chiamati secondo le proprie specializzazioni, compreso la effettuazione delle radiografie ad uso complementare alla attività

Descrizionedelpericolo Durata Gravità Evento I/R
Disturbimuscolo-scheletriciperposizionedilavoro in piedi o
2 1 2 4
incongrue/inadeguate.
Elettrocuzione durante l'utilizzo di attrezzature 2 2 1 4
elettriche.
Infortuni per l'uso di attrezzature manuali e, in particolare
agli arti superiori, per il contatto con parti taglienti ed 3 1 3 9
aghi.
Contatto con materiale organico potenzialmente in fetto
3 3 3 27
(es. sangue, saliva)
Movimentazione Manuale dei Carichi 1 1 1 1
Rischio biologico: contagio con i ceppi virali HSV1 e
HSV2 HBV e HCV, HIV, batteri e virus responsabili
delle infezioni delle vie aeree superiori, agenti 3 3 3 27
eziologicidiaffezionipolmonariviraliebatteriche
(es.legionella)
Inalazione di polveri e vapori/aerosol 3 3 3 27
Irritazioni cutanee da guanti in latice 2 1 2 4
Stress psicofisico causato da orari e ritmi di lavoro
3 1 1 3

eccessivi.
Contatto con detergenti e disinfettanti per la manutenzione
3 1 2 6
igienica dei locali e delle attrezzature.
Rischio daR.I.. 1 3 2 6
Microclima 3 2 1 6
Incendio 1 3 1 3
Rischio elettrico 3 2 1 6
Radiazioni ottiche artificiali (non coerenti) 2 2 2 8

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E DISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Misure di prevenzione e protezione generali

■ Sostituire i prodotti maggiormente nocivi con altri a minore impatto tossicologico.
■ Effettuare ricambi d'aria dei locali in numero adeguato, garantendo una corretta ventilazione.
■ Prevedere un'idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti nello studio.
■ Sono predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione elettrica all'intero impianto (sul quadro generale) e alle singole zone (quadri di settore).
■ Gli utensili elettrici portatili devono essere corredati da un libretto d'uso e manutenzione.
■ Fornire formazione e informazione ai lavoratori sui rischi lavorativi connessi all'uso di disinfettanti e prodotti chimici impiegati in odontoiatria.
■ Durante l'uso di sostanze chimiche devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare il contatto con pelle, occhi e mucose.
■ Adoperare adeguati mezzi di protezione personale (es. creme barriera, guanti in lattice, mascherine, visiere).
■ Ogni sostanza deve essere opportunamente conservata secondo le istruzioni del produttore.
■ Durante l'uso di sostanze chimiche o tossiche è vietato consumare cibi e bevande.
■ Attenersi scrupolosamente a quanto prescritto dall'Esperto Qualificato in materia di Radioprotezione (art. 80 D.Lgs. 230/95 e s.m.i.).
■ Acquisire e tenere a disposizione le schede di sicurezza (SDS) delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate.

■ Predisporre tabelle e istruzioni di primo soccorso per le sostanze impiegate.
■ Attuare misure tecnico-organizzative per ridurre il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni (pause, rotazione dei compiti, turni equilibrati).
■ Scegliere prodotti detergenti con pH vicino alla neutralità.
■ Utilizzare e conservare gli strumenti taglienti con la dovuta attenzione e cura.
■ Utilizzare occhiali protettivi durante l'esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) non coerenti.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) con marcatura "CE"

I lavoratori che eseguono le attività operative devono utilizzare regolarmente i seguenti DPI:

■ Guanti in lattice (per operazioni con contatto con liquidi biologici del paziente, come sangue, saliva, sudore).
■ Indumenti protettivi adeguati (camici o divise da lavoro).
■ Maschera di protezione delle vie respiratorie, da sostituire circa ogni ora o quando si inumidisce.
■ Visiera protettiva durante le operazioni in prossimità del paziente che prevedono l'uso di strumentazione rotante, specialmente ad alta velocità.
■ Occhiali schermanti protettivi per l'impiego di ROA non coerenti.

3. Impiegato amministrativo

In tale gruppo sono considerati gli addetti ai videoterminali, i responsabili dei rapporti con la clientela e con i fornitori

Descrizionedelpericolo Durata Gravità Evento I/R
Uso dei video terminali 3 1 4 12
Urti, colpi, impatti e compressioni 1 1 1 1
Stress psicofisico 3 3 2 18
Rischio biologico: contagio con i ceppi viraliHSV1 e 1 2 2 4
HSV2 HBV e HCV, HIV, batteri e virus responsabili
delle infezioni delle vie aeree superiori, agenti
eziologici di affezioni polmonari virali e batteriche

Punture, tagli ed abrasioni 1 1 2 2
Elettrocuzione 2 1 2 4
Incendio 2 3 1 6
Inalazione di polveri 2 2 2 8
Contatto con sostanze irritanti e allergizzanti 1 1 1 1
Contatto con materiale organico 1 1 1 1

Allergie 1 1 1 1
Rumore 1 1 1 1
Movimentazione manuale dei carichi 1 2 2 4

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E DISTRUZIONI PER GLI ADDETTI

Misure di Prevenzione e Buone Pratiche Operative – Uffici e Aree Amministrative

■ Utilizzare schermi protettivi o filtri per ridurre l'affaticamento visivo durante il lavoro al videoterminale (VDT).
■ Evitare di mantenere posizioni scomode o statiche per tempi prolungati; quando non è possibile, interrompere frequentemente il lavoro per rilassare la muscolatura.
■ Assumere sempre una postura comoda ed ergonomicamente corretta.
■ Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa.
■ Indossare la mascherina durante la sostituzione del toner della fotocopiatrice.
■ Le prese elettriche devono essere correttamente fissate, dimensionate per l'utilizzo previsto e progettate in modo da impedire il contatto accidentale con parti in tensione durante l'inserimento della spina.
■ I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli e mantenuti in buono stato di pulizia.
■ Le attività di pulizia non devono essere svolte contemporaneamente ad altre attività lavorative.
■ L'apertura delle porte non deve generare situazioni di pericolo: i passaggi devono essere sgombri da ostacoli, le maniglie prive di spigoli vivi e facilmente accessibili.
■ L'impianto idraulico deve fornire acqua fredda e calda, detergenti e mezzi idonei per l'asciugatura delle mani; i locali devono essere mantenuti puliti e ordinati.
■ Mantenere una scrupolosa igiene personale, con lavaggio frequente delle mani.
■ Garantire che temperatura e umidità dei locali siano mantenute entro i limiti del benessere termico; evitare attività rumorose nelle aree aperte al pubblico, salvo la normale rumorosità ambientale.
■ **Le sedie devono essere ergonomiche e stabili:**

o i sedili fissi devono garantire stabilità;
o i sedili mobili devono avere cinque razze;
o i comandi per le regolazioni (altezza, schienale, supporto lombare) devono essere facilmente accessibili;
o ove necessario, fornire poggiapiedi regolabili.
■ I tavoli e le scrivanie devono avere superfici opache e prive di spigoli vivi.
■ Gli scaffali devono essere ben fissati alla parete o alla struttura portante e recare l'indicazione del carico massimo per ciascun ripiano.
■ L'utilizzo degli scaffali deve essere agevole e sicuro, anche in caso di impiego di scale, sgabelli o altri accessori.
■ **Le macchine da ufficio alimentate elettricamente devono:**

o essere collegate all'impianto di messa a terra tramite spina di alimentazione, oppure

o possedere un doppio isolamento (doppia protezione), garantito da marchio CE e documentazione del fabbricante.

4. Pazienti

In tale gruppo sono considerati i pazienti dello studio odontoiatrico

Descrizionedelpericolo Durata Gravità Evento I/R
Scivolamenti a livello 2 2 1 4
Urti e impatti con spigoli vivi degli arredi a corredo dello
2 2 1 4
studio
Rischio biologico: contagio con i ceppi virali HSV1 e
HSV2 HBV e HCV, HIV, batteri e virus responsabili
delle infezioni delle vie aeree superiori, agenti eziologici 3 3 2 18
di affezioni polmonari virali e batteriche
(es.legionella eSars-Cov2)
Inalazione di polveri e vapori/aerosol 1 2 1 2
Rischio daR.I.. 1 3 2 6
Microclima 3 2 1 6
Incendio 1 3 1 3
Rischio elettrico 3 2 1 6
Radiazioni ottiche artificiali (non coerenti) 2 2 2 8

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE E DI STRUZIONI PER GLI ADDETTI

■ Effettuare ricambi d'aria dei locali in numero adeguato, garantendo una corretta ventilazione naturale o meccanica.
■ Manutenere e sanificare i filtri dei condizionatori con cadenza trimestrale, utilizzando prodotti

disinfettanti ad ampio spettro, specifici contro batteri Gram-negativi (es. Legionella) e virus Sars-CoV-2 (es. ipoclorito di sodio in soluzione al 2%).
■ Sono predisposti comandi di emergenza per interrompere rapidamente l'alimentazione all'intero impianto elettrico (sul quadro generale) e a sue parti (sui quadri di zona);
■ La manutenzione dei presidi antincendio deve essere effettuata con cadenza semestrale.
■ Gli apparecchi elettromedicali devono essere verificati con cadenza biennale.
■ Leoperazioni di pulizia e specificatamente di lavaggio dei pavimenti deve essere effettuata al termine della giornata lavorativa e comunque in assenza di pubblico.
■ Attenersi a quanto prescritto dall'Esperto Qualificato in materia di Radioprotezione (art.131D.Lgs.

100/2020)

■ Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate
■ Durante la attesa è obbligatorio l'uso di mascherine possibilmente del tipo FFP2
■ Uso degli occhiali protettivi durante l'esposizione a ROA non coerenti

5. Ambienti di lavoro

Rischi di natura infortunistica

Pavimenti

■ I pavimenti non presentano avvallamenti e parti in rilievo; non sono scivolosi e sono facilmente lavabili.
■ Le attività di pulizia non devono essere effettuate in concomitanza con le altre attività.
■ Devono avere le fughe integre;
■ Le piastrelle devono essere prive di sbeccature o tagli profondi.

Pareti e soffitti
■ Hanno una superficie liscia, integra, non polverosa, lavabile e di colore chiaro (colori pastello). Gli spigoli non devono presentare lesioni o disuniformità; gli zoccolini devono essere integri, privi di sporgenze e ben fissati alla parete.
■ Verificare che le pareti siano prive di sporgenze o chiodi.
■ I rivestimenti dei servizi devono essere uniformi, integri, privi di asperità e facilmente lavabili.
■ Le pareti trasparenti e in particolare le pareti vetrate devono essere segnalate.

Porte
■ L'apertura di porte non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione che per altre persone. Devono essere mantenute sgombre da ostacoli, avere maniglie prive di spigoli vivi ed essere facilmente accessibili. Le porte trasparenti, devono essere segnalare ad altezza occhio (1,5 - 1,8 mt.). Le porte devono inoltre essere conformi alla normativa vigente, dimensionate e posizionate correttamente a secondo del loro utilizzo (porte d'ingresso, porte interne).

Finestre
■ L'apertura delle finestre, non deve generare situazioni pericolose sia per chi compie l'operazione che per altre persone. Esse vanno dotate di idonei sistemi di schermatura (ad es. tende regolabili di colore chiaro) per evitare fastidiosi abbagliamenti, inoltre devono garantire un buon ricambio d'aria.
■ le cinghie delle persiane avvolgibili devono essere mantenute in buone condizioni e controllate periodicamente.
■ la conformazione delle finestre deve essere tale da consentire le operazioni di pulitura in condizioni di sicurezza o dotati di dispositivi o attrezzature atte a conseguire il medesimo risultato.

Servizi
■ i servizi devono servire pubblico e operatori.
■ L'impianto idraulico deve erogare acqua fredda e calda e devono essere forniti i detergenti e i mezzi per asciugarsi. I locali vanno tenuti puliti. Le pareti sono piastrellate sino ad una altezza di mt. 2.20

Passaggi
■ i corridoi e i passaggi in genere devono essere liberi da ostacoli ed avere sempre un livello di illuminamento sufficiente; eventuali dislivelli o riduzioni in altezza devono essere segnalati e non devono ridurre a meno di mt. 2 il vano utile percorribile.

Analisi

L'analisi del ciclo di lavoro ha evidenziato la presenza di attività che implicano l'esposizione ad agenti biologici di cui all'art. 266 e seguenti del D.Lgs 81/2008

Gli agenti biologici, sono classificati in quattro gruppi:

Gruppo1: gli appartenenti a questo gruppo presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani
Gruppo2: le probabilità di causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori aumentano. Difficilmente la malattia si propagherà nella comunità. Sono di norma disponibili

efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Gruppo3: elevate probabilità di causare malattie gravi in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori. L'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
Gruppo 4: le probabilità di determinare malattie in soggetti umani e costituire un serio rischio per i lavoratori sono elevatissime. E' frequente la propagazione nella comunità; non sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
A titolo di esempio, i virus HIV e HBV sono inclusi nel gruppo 3.
La popolazione microbica del cavo orale è composta sia di microrganismi assolutamente innocui

che di agenti eziologici di patologie infettive tra le quali le più comuni sono:

- VirusHerpesSimplexHSV1eHSV2
- Virusdell'epatiteBeC(HBVeHCV)
- Virusdell'AIDS(HIV)
- Batteri e virus responsabili delle infezioni delle vie aeree superiori.
- Agenti eziologici di affezioni polmonari virali e batteriche (es. tubercolosi).

I fattori che concorrono alla trasmissione degli agenti patogeni negli ambienti dello studio sono da ricercarsi nel continuo passaggio di persone, caratteristica dell'attività professionale, nellamancanza di sistemi di isolamento tra sala operatoria ed ambiente esterno, nella continuaproduzione di contaminanti ad alto rischio (liquidi organici) e nella grande quantità di materiali, strumenti ed oggetti impiegati. Tutto ciò favorisce la contaminazione crociata, cioè la trasmissione diunamalattiainfettivatramitecontagiodirettoe/oindirettodaunportatorealaltrapersona. Insala operatoria invece, la contaminazione degli operatori oltre che per diretto contatto con liquidi biologici contaminati può avvenire anche per ricaduta di particelle, di dimensione compresa tra 0.5550um.Esse restano sospese per circa 24 ore, e le più piccole (il 95% circa) arrivano fino al livello degli alveoli polmonari.
Possono essere individuati dei sistemi cosiddetti "barriera" che si frappongono tra la pelle o lo strumentario e gli agenti patogeni. A tale categoria appartengono i guanti, la pellicola trasparente, le mascherine oro-nasali, occhiali, visiere.

I guanti dovrebbero essere in latice di gommao al limite in vinile in caso di allergie al latice; le mascherine oro-nasali sono di buona qualità se la BFE (BacteryFiltrationEfficiency) è superiore al 90% ed inoltre dovrebbero essere sostituite circa ogni ora dal momento che l'umidità riduce la capacità filtrante.
Alla conclusione di ogni intervento, tutto lo strumentario contaminato deve essere trasportato nell'area di sterilizzazione ed essere sottoposto a dei cicli per la decontaminazione, detersione e disinfezione. A tal fine gli strumenti devono essere preventivamente immersi in bagno di glutaraldeide al 2% per 30' per ridurre la carica batterica cambiando la soluzione quotidianamente.
Successivamente la metodica ad ultrasuoni è la più impiegata in odontoiatria; si dovrà evitare di mescolaremetallidiversichepotrebbedareluogoaprocessielettroliticiconconseguentecorrosione e/o colorazione. La vaschetta con la soluzione detergente durante il ciclo deve essere tenuta coperta per evitare la produzione di aerosol.
A fine giornata lavorativa è consigliabile effettuare una disinfezione approfondita della sala operativa pulendo attentamente oltre che il corpo del riunito anche la sua base ed i mobiletti e il lavandino. Tra il paziente e l'altro sarebbe opportuno isolare con pellicola trasparente la lampada, i comandi manuali della poltrona e della faretra del riunito, gli aspiratori chirurgici, la testata del radiografico. Prima di ogni seduta si potrebbe chiedere al paziente uno sciacquo con clorexidina al

0.2% per un minuto.

La profilassi per gli operatori, in previsione, sarà garantita da ciclo vaccinale.

Le responsabilità per la prevenzione e il controllo delle infezioni correlate all'assistenza sono:

- a capo dell'Odontoiatra che effettua la prestazione clinica. Lo stesso supervisiona con responsabilità diretta le eventuali ASO per le fasi di preparazione della sala operativa e, successivamente al congedo del paziente, alla sua sanificazione.

Protocolli tecnici per la prevenzione dell'esposizione a Legionella
La legionella è un batterio Gram- che si sviluppa all'interno di biofilm nei circuiti idrici con possibilità di permanenza di acqua stagnante. Il range di temperatura di proliferazione è compreso tra 20 e 55 °C, raggiungibili ovviamente nei circuiti di distribuzione di acqua calda sanitaria, impianti di condizionamento a termosifone, e circuiti idrici in prossimità di circuiti/apparecchiature elettriche che durante il loro normale funzionamento raggiungono la temperatura di circa 35°Ccome il caso delle poltrone odontoiatriche.
Al fine di procedere alla valutazione del rischio è stata effettuata la ricognizione all'interno della struttura del circuito idrico nel suo complesso, dall'approvvigionamento comunale sino alle singole utenze.
Le risultanze hanno escluso la presenza di rami morti e/o in disuso, e la configurazione "in serie" della riserva idrica indipendente posta tra la fornitura comunale e il collettore di smistamento,

assicurando un continuo ricambio dell'acqua al suo interno. La stessa riserva idrica è semestralmente sanificata con soluzione di Amuchina, il cui principio attivo è l'ipoclorito di sodio 1,15 g che nello spettro di azione contempla elettivamente i batteri Gram-.

Il riunito odontoiatrico si compone del gruppo di adduzione (siringa aria/acqua, ablatore, micromotore, contrangolo, bicchiere) e dello scarico (vaschetta sputacchiera ed aspirazione localizzata) con circuiti ovviamente separati.
Premesso che quotidianamente al termine della giornata lavorativa l'assistente alla poltrona provvede alla sanificazione e sterilizzazione del gruppo aspirazione con prodotto apposito tramite circolazione in matrice chiusa (escluso ogni possibile contatto e/o inalazione) di soluzione adatta alla tipologia di riunito, periodicamente (con cadenza semestrale) un tecnico autorizzato provvedeal "lavaggio e sanificazione" del gruppo di adduzione in modalità differenti a seconda della

classificazione e modello del riunito stesso:

■ Lavaggio a pressione (circa 2,5 bar) con soluzione (2%) di acido per acetico e tempo di permanenza del gruppo idrico di circa 10 minuti con successivo risciacquo
■ Lavaggio con acqua ossigenata (per ossido di idrogeno) al3%
Per ridurre la contaminazione microbica e/o la formazione del biofilm all'interno dei circuiti idrici

del riunito, si raccomanda di:

■ Eliminare dal circuito i tratti esclusi dalle correnti di flusso.
■ Installare dispositivi anti-ristagno in grado di far circolare l'acqua in continuo, in particolare durante le pause lavorative.
■ Alimentare il circuito con soluzioni sterili, dopo averlo isolato dalla rete idrica.
■ Disinfettare l'acqua con trattamenti in continuo o discontinui. Questi ultimi, effettuati periodicamente o tra un paziente e il successivo utilizzando disinfettanti di alto livello, evitano la possibilità di contaminazioni chimiche del campo operatorio, riducono l'esposizionedeglioperatorieminimizzanoilrischiodiselezionaremicrorganismiresistenti, ma richiedono maggiore impegno di risorse e attenzione rispetto ai trattamenti in continuo.

Per ridurre l'esposizione del paziente ad aerosol potenzialmente contaminati e/o minimizzare il rischio di infezione.

Il rischio nei pazienti più vulnerabili si consiglia di:

• All'inizio della giornata lavorativa, effettuare la disinfezione dei circuiti con soluzioni a base di acido peracetico e successivo flussaggio di ciascuno strumento (tempo minimo 2 minuti) e prima di ogni intervento (tempo minimo 20–30 secondi).

• A fine giornata lavorativa, eseguire la disinfezione dei circuiti, della vaschetta e del bicchiere con soluzioni a base di acido peracetico e successivo flussaggio di ciascuno strumento (tempo minimo 2 minuti) e prima di ogni intervento (tempo minimo 20–30 secondi).

• Installare, subito a monte dei manipoli, filtri (≤ 0,2 μm) in grado di trattenere i microrganismi provenienti dall'interno del circuito.

• Acquisire, preliminarmente all'inizio delle cure, informazioni sulla salute del paziente, con particolare riguardo alle condizioni che definiscono il "rischio molto elevato" (Tabella 9). In tali casi, devono essere rigorosamente adottate le misure sopra descritte, volte a contenere il rischio di contaminazione da Legionella.

Si provvederà a far eseguire annualmente una analisi di laboratorio di campioni d'acqua prelevati dal circuito di adduzione dei riuniti (bicchiere, manipoli e siringa) per la ricerca del batterio della legionella.

I filtri dei condizionatori saranno smontati e sanificati semestralmente con soluzione a base di

ipoclorito di sodio o disinfettante spray secondo la seguente sequenza:

1 Rimozione filtro
2 Aspirazione polveri
3 Sgrassaggio
4 Sterilizzazione/Disinfezione/Sanificazione (per immersione almeno 30 min in soluzione, o in alternativa trattamento con spray specifico
5 Posizionamento filtro

Il titolare e gli eventuali futuri dipendenti o collaboratori faranno uso costante dei DPI, seguiranno le procedure di disinfezione dei piani di lavoro e delle attrezzature odontoiatriche (lampada e riunito) dopo ogni seduta, ed effettueranno il ricambio d'aria naturale tra un paziente e l'altro.
Si valuterà la necessità dell'istituzione della sorveglianza sanitaria tramite la nomina di un Medico Competente.

Firme per presa visione dei dipendenti e collaboratori

Il presente documento è stato letto, compreso e accettato da tutti i dipendenti e collaboratori dello Studio.

Con la firma apposta, ciascun lavoratore dichiara di aver preso visione del contenuto, di essere stato informato sulle procedure e sulle misure di sicurezza da adottare, e di impegnarsi al rispetto delle stesse.

N. Nome e Cognome Qualifica / Mansione Firma Data

2

4

Il piano sarà aggiornato nel caso di eventi straordinari e ogni qual volta sia necessario con la adozioni di eventuali misure aggiuntive.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 30:

Procedura per la pulizia e sanificazione degli ambienti

Cod. Requisito
1A.06.02.02

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 30

Cod. Requisito 1A.06.02.02 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

INDICE

Generalità 2

Scopo 2

Campo di applicazione..... 2

Attività 3

Identificazione delle aree 4

Valutazione dei criteri igienico sanitari riferiti alle aree 4

Definizione dei protocolli di sanificazione 4

Scelta degli agenti sanificanti 6

Sanificazione ordinaria 7

Sanificazione straordinaria..... 7

Registrazione attività svolta 7

GENERALITÀ

Per garantire l'igiene è necessario effettuare quattro distinte operazioni:

1. Eliminazione dei rifiuti speciali

2. Eliminazione dei rifiuti normali

3. Detersione

4. Disinfezione

Per l'eliminazione dei rifiuti speciali vanno utilizzati gli appositi contenitori forniti dalla ditta specializzata checura il ritiro e la successiva eliminazione; i contenitori dei rifiuti speciali devono essere tenuti costantementechiusi emantenutinellezonepreviste.

Per l'eliminazione dei rifiuti normali, durante le operazioni quotidiane di igienizzazione, provvedere al lorodepositocomeprevistodalledisposizionicomunali.
Il Responsabile Qualitàdeve controllare cheil personaleaddettoalle pulizie effettui leoperazioni diigienizzazionesecondo la frequenza e le modalità stabilite nel presente documento e, al termine delle operazioni, deve provvedere alla registrazione sul documento–Scheda Pulizia e Sanificazione.
Sino al momento della assunzione di personale, le operazioni di pulizia e sanificazione dello studio sarannosvoltedirettamentedalTitolare.

SCOPO

Scopo della presente proceduraè assicurare che vengano rispettate tutte le operazioni per la puliziadei locali pressolostudio.

CAMPODIAPPLICAZIONE

L'istruzione si applica a tutte le aree operative e non dello studio.

ATTIVITÀ

Sono qui descritte sinteticamente le attività dell'igiene degli ambienti per mezzo di un diagramma di flusso.

Identificazione
delle aree

Valutazione dei criteri
igienico sanitari delle
Singole aree

Definizione del

Scelta degli agenti
protocollo di
sanificanti
Sanificazione

Controllo periodico
Sanificazione
della conformità
Ordinaria

NO

Sanificazione
straordinaria

Scheda
Registrazione
sanificazione

Identificazione delle aree

Lo studio ha identificato le seguenti aree:

a) Sala d'attesa
b) Segreteria/ufficio
c) Sala personale
d) Sala operativa (1)
e) Sala operativa (2)
f) Sala sterilizzazione
g) Servizio igienico clienti
h) Servizio igienico personale
i) Ingresso - Corridoio
j) zona tecnica

Valutazione dei criteri igienico sanitari riferiti alle aree

La sanificazione degli ambienti di lavoro va riferita alla destinazione d'uso degli ambienti e quindi alla potenziale contaminazione legata alla specifica attività.

Per tale motivo vanno distinti:

■ AMBIENTI A RISCHIO GENERICO (zona di attesa, corridoi, ufficio amministrativo, spogliatoio) (ZONA1)
■ AMBIENTI A BASSO RISCHIO (Servizi igienici) (ZONA2)
■ AMBIENTI A MEDIO RISCHIO (sale operative) (ZONA3)
■ **SERVIZI IGIENICI (ZONA4)**

Definizione dei protocolli di sanificazione.

La sanificazione degli ambienti di lavoro comprende le seguenti operazioni:

Locali:

a) Sala d'attesa
b) Segreteria/ufficio
c) Sala personale

Attività giornaliera:

■ Sostituzione dei sacchi dei rifiuti dai cestini, pulire questi ultimi con panno umido, quindi introdurre il sacchetto nuovo. Mediante panno inumidito con detergente, asportare la polvere dalle mensole, dai tavoli e dalle suppellettili varie e dagli arredi, nonché dai davanzali interni e dagli interruttori.
■ Sempre con panno umido, eliminare le tracce di sporco e di impronte da porte, stipiti, vetri e maniglie, telefoni; per maniglie e telefoni è opportuno utilizzare successivamente un panno umido intriso di soluzione disinfettante.
■ Lavare i pavimenti con l'uso di MOP a doppio secchio; devono essere previsti almeno due passaggi: uno di detersione e il successivo di risciacquo. Ricordarsi di sostituire periodicamente i panni utilizzati.

AttivitàMensile:

■ Pulizia delle tastiere dei computer con aria compressa.
■ Lavaggio finestre, porte, pareti, armadi, vetrine

Sale Odontoiatriche e sterilizzazione

d) Sala operativa (1)
e) Sala operativa (2)
f) Sala sterilizzazione

Durante l'attività:

- Disinfezione delle superfici di lavoro e/o dei pavimenti tutte le volte che si presenti la necessità (Per esempio, in caso di caduta accidentale di un campione biologico o di sostanze potenzialmente infette.)
- Turbine, ablatori, contrangoli, inserti

Attività Giornaliera:

- Pulizia superfici esterne attrezzature, alogene, riuniti, negativoscopio, autoclave, vasca ultras, ablatore. Lavaggio tubi di aspirazione. Lavaggio filtri aspirazione
- Disinfezione circuiti (prevenzione legionellosi)
- Aprire le finestre per aerare gli ambienti
- Disinfezione di tutte le superfici di lavoro
- Disinfezione lettighe
- Disinfezione pavimenti di tutte le aree di lavoro
- Disinfezione del lavandino
- Sostituzione sacchi rifiuti
- Sostituzione contenitori rifiuti speciali (o in accordo alle condizioni di contratto con la società addetta allo smaltimento)

Attività settimanale
- Pulizia vasca ultrasuoni
- Pulizia camera sterilizzazione dell’autoclave

AttivitàMensile:

- Lavaggio finestre, porte, pareti, armadi, vetrine
- Scarico condensa compressore;
- Lampade.

Servizi igienici

Durante l'attività:

- Il titolare ed eventualmente il futuro personale da lui incaricato, ha il compito di controllare periodicamente le condizioni igieniche dei servizi e prevedere la disinfezione lasciandone traccia su apposito documento di registrazione.
- Provvederà inoltre alla sanificazione tutte le volte che sene presenti la necessità (per es. caduta accidentale di un campione biologico o di sostanze potenzialmente infette)

Attività Giornaliera:

- Detergere i lavabi con prodotto specifico, quindi risciacquare abbondantemente ed igienizzare con derivati del cloro; asciugare accuratamente la rubinetteria.
Periodicamente devono essere asportate dai lavabi e dalla rubinetteria le incrostazioni calcaree, con intervento meccanico o chimico.

- Pulire lavabi e water con polveri leggermente abrasive, risciacquare e disinfettare; versare nei sifoni una soluzione di idoneo detergente.
- Lavare i pavimenti
- Eseguire il lavaggio dei servizi igienici nel seguente ordine: con panno spugna inumiditocon detergente pulire i coperchi dei WC, quindi sciacquarli, proseguire poi con la pulizia dei vasi, utilizzando lo scopino e tirando lo sciacquone, infine igienizzare con candeggina
- Controllo e sostituzione carta igienica e rotoloni asciugamani
- Pulizia piastrelle e porte

Al termine delle operazioni di sanificazione, il responsabile di tale attività, registra la stessa in apposite schede di registrazione (vedi allegati alla presente procedura).

Scelta degli agenti sanificanti.
La scelta degli agenti sanificanti viene effettuata dal Titolare.

Per la disinfezione di tutte le superfici vengono utilizzati disinfettanti dotati dei seguenti requisiti:

■ Largo spettro di attività antibatterica.

■ Bassa inattivazione da parte di materiale organico.
■ Lunga attività residua sulle superfici trattate.
■ Assenza di azione irritante o tossica per l’operatore.

Sanificazione ordinaria

Il disinfettante viene ciclicamente (ogni anno o ogni qualvolta sorgano dubbi sulla sua efficacia) sostituito con un altro che soddisfi gli stessi criteri. I disinfettanti utilizzati per tutte le superfici sono il benzalconio cloruro e l'ipoclorito di sodio.
Il disinfettante spray per ambienti e superfici contiene cloruro d'ammonio e cloruro benzilammonio

Sanificazione straordinaria
Quella stabilita dal programma di sanificazione.
La disinfezione di maniglie delle porte, interruttori, suppellettili e di tutte le parti ad uso promiscuo avverrà periodicamente tramite nebulizzazione di spray disinfettante.
La disinfezione delle attrezzature va eseguita ad oggi (in assenza di personale) dal Titolare, e in futuro dall'assistente alla poltrona sotto la direzione dell'odontoiatra.

Sarà effettuata in caso di riscontro di pazienti con patologie potenzialmente contagiose (es. Sars-CoV-2).

Registrazione attività svolta

Il personale addetto, al termine delle operazioni di sanificazione, registra la propria attività sull'apposita scheda di sanificazione.

IGIENEDELPERSONALE

È vietato fumare all'interno di tutti i locali della struttura, a partire dalla zona di attesa.

L'abbigliamento in dotazione, costituito da camici in cotone pesante, deve essere conservato negli appositi armadietti personali situati nello spogliatoio ed indossato all'inizio di ogni giornata, assicurandosi che sia pulito e provvedendo, eventualmente, al cambio.

Le mani devono essere prive di anelli e di bigiotteria, avere sempre le unghie corte e non coperte da smalti; eventuali ferite o abrasioni devono essere ben protette da medicazioni impermeabili atte a garantirne l'isolamento.

Le operazioni di igiene personale vanno condotte con la seguente frequenza e modalità:

• ogni volta che si rientra dall'esterno
• prima di ogni prestazione effettuata sui pazienti
• prima di ogni contatto con materiale sanitario o con alimenti
• dopo ogni contatto con oggetti potenzialmente inquinanti
• dopo l'utilizzazione dei servizi igienici

Per l'igienizzazione devono essere utilizzati prodotti a base di tensioattivi vegetali e triclosan o

benzalconio, con pH compreso tra 5,5 e 6,5, ed effettuati i necessari risciacqui; le parti lavate andranno asciugate utilizzando tessuto o carta idonea monouso.

ALLEGATI

1 Schedapuliziaesanificazione

Firmeperpresavisione deilavoratoriedipendenti

NOMEE COGNOME FIRMA

SCHEDAI GIENIZZAZIONE BAGNI

BAGNO ADIACENTE ALLA SALA D'ATTESA

Il presente modulo dovrà rimanere affisso nei bagni sino al termine della compilazione e va aggiornato quotidianamente. Scrivere in
stampatello leggibile. Al termine consegnare in Direzione.

Durante le attività: Attività Giornaliera:

Il personale addetto, nelle ore destinate al ricevimento del pubblico, ha il compito di controllare ogni Detergere i lavabi con un prodotto specifico, quindi risciacquare abbondantemente e igienizzare con derivati
del cloro; asciugare accuratamente la rubinetteria. Periodicamente devono essere asportate dai lavabi e dalla
2 ore le condizioni igieniche dei servizi e procedere alla disinfezione, lasciandone traccia su apposito rubinetteria le incrostazioni calcaree, mediante intervento meccanico o chimico.
documento di registrazione. Provvederà inoltre alla sanificazione tutte le volte che se ne presenti la Pulire lavabi e water con polveri leggermente abrasive, risciacquare e disinfettare; versare nei sifoni una
soluzione di idoneo detergente. Lavare i pavimenti.
necessità (ad esempio in caso di caduta accidentale di un campione biologico o di sostanze
potenzialmente infette). Eseguire il lavaggio dei servizi igienici nel seguente ordine: con panno spugna inumidito con detergente pulire
i coperchi dei WC, quindi sciacquarli; proseguire con la pulizia dei vasi utilizzando lo scopino e tirando lo sciacquone; infine igienizzare con candeggina.

Controllare e, se necessario, sostituire la carta igienica e i rotoloni asciugamani. Procedere alla pulizia delle

piastrelle e delle porte.

Mese Mese
Data Orario Operatore Data Orario Operatore

Rev. N ____del_____

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 31:

Procedura per la protezione dagli incidenti per esposizione a materiale biologico o altre sostanze pericolose

Cod. Requisito
1A.06.02.03

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 31

Cod. Requisito 1A.06.02.03 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

Incidenti per esposizione a materiale biologico
Gli operatori odontoiatri ed eventualmente le Assistenti di Studio Odontoiatrico possono essere soggetti ad incidenti che li espongano a materiale biologico. (Al momento non è presente altro personale in studio)

Gli stessi possono essere di seguito elencati:

- Contatto accidentale con sangue del paziente durante l'impiego di bisturi
- Contatto accidentale con liquido anestetico
- Esposizione a radiazioni ottiche artificiali non coerenti (lampade fotopolimerizzatrici)
- Ferite da taglio o da punta

Procedura:

Premesso che il Titolare ed eventualmente tutti gli eventuali collaboratori e personale di supporto (ASO) saranno formati ed informati sui rischi relativi alla mansione specifica, sarà obbligatorio indossare durante le **sedute con i pazienti i seguenti dispositivi di protezione individuale:**

- Visiera para schizzi
- Guanti in latice
- Camice in TNT
- Cuffie in TNT
- Mascherine in TNT
- Occhiali di protezione per ROA non coerenti (all'occorrenza durante i cicli di polimerizzazione)

Tutti i materiali di scarto impiegati durante la seduta odontoiatrica (es. rulli salivari, cannule, bicchieri, teli e monouso vari, scarti organici) vanno conferiti all'interno del contenitore dei rifiuti speciali. Stessa cosa andrà fatta per i DPI potenzialmente infetti.

Ai fini della prevenzione delle ferite da taglio o da punta lo studio segue le seguenti norme procedurali:

NORME PER L'USO DI AGHI E TAGLIENTI

Le norme per l'uso di aghi e taglienti (bisturi, lancette, lame, ecc.) sono fondamentali per garantire la sicurezza degli operatori sanitari e dei pazienti, prevenendo in particolare punture accidentali e infezioni da agenti biologici (come HIV, HBV, HCV).

Ecco le principali linee guida e buone pratiche:

1. Principi generali

- Utilizzare aghi e taglienti solo quando strettamente necessario.
- Evitare di passare aghi o strumenti taglienti di mano in mano: utilizzare vassoi o superfici neutre.
- Maneggiare sempre con attenzione, tenendo il dispositivo puntato lontano da sé e dagli altri.
- Non piegare, rompere o reincappucciare gli aghi dopo l'uso.
- Procedere con la massima attenzione per prevenire punture o tagli.
- Laddove occorra praticare su uno stesso paziente iniezioni multiple di anestetico o di altri farmaci da una singola siringa, è prudente, nell'intervallo tra una iniezione e un'altra, proteggere l'ago nodo in un tubo sterile, piuttosto che incappucciarlo.
- Smaltire aghi, siringhe, lame di bisturi e altri taglienti negli appositi contenitori rigidi resistenti alla foratura.
- Non manipolare o tenere con sé siringhe o taglienti usati, oltre il tempo strettamente necessario.

- Non disconnettere manualmente gli aghi dalle siringhe o le lame di bisturi dal portalame e non piegare, spezzare o manipolare in qualunque modo gli aghi.
- Non manipolare gli aghi usati con entrambe le mani. (operazioni con una sola mano)
- Non infilare gli aghi nei set di infusione.
- Non rivolgere mai la punta dell'ago verso il corpo.
- Utilizzare aghi con sistemi di protezione.
- Durante l'uso di aghi e taglienti, gli altri operatori devono tenere le mani lontano dal campo interessato dall'operazione a meno che non sia richiesto il loro aiuto.
- Contenitori resistenti alla puntura devono essere sistemati in vicinanza ed in posizione comoda, rispetto al posto dove devono essere utilizzati.

■ Non rompere, manipolare, piegare gli aghi usati con le mani.
■ I contenitori di sicurezza non vanno riempiti fino all'orlo ma al massimo per 3/4 (salvo attenersi alle indicazioni di massimo livello presenti sugli stessi) e alla fine del riempimento vanno chiusi in maniera definitiva.

2. Dispositivi di protezione individuale (DPI)

■ Indossare guanti monouso (e, se necessario, doppi guanti).
■ Usare camici, mascherine, occhiali o visiere per proteggere da schizzi di sangue o liquidi biologici.
■ Sostituire i guanti in caso di rottura o contaminazione.

3. Utilizzo corretto

■ Utilizzare solo dispositivi sterili e integri.
■ Non manipolare aghi e taglienti inutilmente dopo l'uso.
■ Eliminare immediatamente gli aghi e taglienti usati nei contenitori dedicati, senza lasciarli su superfici o carrelli.
■4. Smaltimento
Questi rifiuti devono essere raccolti in contenitori rigidi in polipropilene gialli, specifici per taglienti, da lt. 3 o 6 o di capacità ancora inferiore.
Questi contenitori una volta riempiti al massimo per ¾ e chiusi ermeticamente, devono essere messi nei contenitori per i rifiuti da lt. 60 utilizzati per gli altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede precauzioni particolari in funzione della prevenzione di infezioni.

■ Utilizzare contenitori rigidi, resistenti alla perforazione, chiaramente identificabili, posizionati vicino alla zona di utilizzo.
■ Non riempire oltre i 2/3 del volume del contenitore.
■ Non tentare mai di comprimere o svuotare i contenitori per recuperare spazio.
■ Smaltire secondo le normative sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (D.Lgs.
81/2008 e s.m.i., D.P.R. 254/2003).

■ 5. In caso di puntura o ferita accidentale

1. Non far sanguinare la ferita in modo forzato.

2. Lavare immediatamente con acqua e sapone.

3. Disinfettare con antisettico (es. clorexidina o iodopovidone).

4. Segnalare immediatamente l'incidente al responsabile o al medico competente.

Studio Sabiu SRL
Dott.ssa Barbara Sabiu
Via Don Minzoni 20
San Giovanni Suergiu (SU)

DOCUMENTO 32:

Sistema (Piani di intervento/report) per l'identificazione e la segnalazione di near miss, eventi avversi ed eventi sentinella

Cod. Requisito
1A.06.02.04

REV. 1/2026

DOTT.SSA BARBARA SABIU

DOCUMENTO 32

Cod. Requisito 1A.06.02.04 - REV. 1/2026

Studio: Studio Sabiu SRL
Responsabile Sanitario: Dott.ssa Barbara Sabiu
Direttore Tecnico: Dott.ssa Barbara Sabiu
Sede: Via Don Minzoni 20, San Giovanni Suergiu (SU)
ASP: ASP Carbonia-Iglesias

I near miss mettono in luce criticità impreviste e improvvise sul luogo di lavoro, riguardanti contesti di tipo organizzativo, tecnico o comportamentale.

La procedura di segnalazione e analisi degli infortuni mancati (anche detti “incidenti” nel documento Inail) avviene su base volontaria.

In concreto, si tratta di un flusso di comunicazione che ha lo scopo di segnalare, registrare e **comunicare gli incidenti non dannosi. Gli obiettivi sono molteplici:**

■ Identificare, raccogliere e analizzare gli incidenti che si verificano sul lavoro e che riguardano il personale o il pubblico, tramite modulistica appropriata;
■ Valutare le situazioni di non conformità o di criticità organizzative, tecniche, procedurali o comportamentali che precedono gli incidenti;
■ Individuare e applicare le adeguate misure correttive e preventive;
■ Garantire un’opportuna comunicazione biunivoca e assicurare un’immediata risposta alla segnalazione: sia nella fase iniziale che in quella di lavorazione sullo stato di avanzamento e trattazione della segnalazione, fino all’esito finale.

Per rendere effettivo questo strumento di prevenzione è fondamentale la partecipazione di tutte le componenti dello studio, in particolare attraverso feedback tempestivi e condivisione delle problematiche.

Le figure e i gruppi coinvolti nella gestione dei mancati infortuni sono:

■ Lavoratore che effettua la segnalazione di incidente: può essere coinvolto o meno nello stesso, e appartenere sia al personale aziendale che alle ditte appaltatrici;

■ Soggetto coinvolto nell’incidente: può essere diretto dipendente, oppure una qualsiasi figura (cliente, fornitore, ecc.) che si trova in prossimità del luogo la cui titolarità è dell’azienda;

■ Gruppo di ricezione, trasmissione, valutazione degli incidenti (GRTVI): è composto da DL, RSPP, RLS. Riceve la segnalazione dell’incidente, valuta e adotta le necessarie misure correttive;

■ Gruppo risoluzione incidenti (GRI). Si occupa di valutare la risoluzione degli incidenti qualora il GRTVI non sia stato in grado di risolvere l’incidente in reparto e, conseguentemente, verifica la concreta efficacia delle soluzioni adottate;

■ DL - datore di lavoro: riceve le comunicazioni dal GRI e verifica l’efficacia delle soluzioni adottate nel caso di incidente non risolvibile in reparto, oppure in caso di incidente non risolvibile in azienda e risolvibile dalle ditte appaltatrici. Verifica, inoltre, la chiusura dell’incidente da parte del GRI.

NEAR MISS: MODALITÀ OPERATIVE DI COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO MANCATO

Le modalità operative per la gestione degli infortuni mancati seguono 5 step:

1. Redazione/registrazione/archiviazione;

2. Coinvolgimento;

3. Verifica;

4. Approvazione;

5. Attuazione.

Il flusso di comunicazione del near miss è organizzato secondo dei moduli o feedback di differenti livelli, corrispondenti alle diverse azioni messe in atto dai soggetti coinvolti. Vediamo i **principali passaggi:**

■ il lavoratore che effettua la segnalazione o eventuale testimone segnala l’incidente all’incaricato, che provvede a comunicarlo a SPP e RLS);
■ l’incaricato comunica al lavoratore l’avvenuta ricezione
■ il GRTVI valuta se la segnalazione sia da riconoscere come incidente. In caso negativo,

l’incaricato o il GRTVI consegna motivata comunicazione al lavoratore che effettua la segnalazione di non presa in carico. In caso positivo, il GRTVI deve decidere se l’incidente è risolvibile in reparto o meno;

■ se la soluzione è gestita dal reparto, il GRTVI provvede a risolvere il problema, manda relazione delle modalità esecutive adottate ai diversi responsabili e comunica al lavoratore che effettua la segnalazione la risoluzione dell’incidente ;

■ qualora non sia risolvibile in reparto, il GRTVI richiede l’ausilio del GRI per mezzo del modulo per la risoluzione di incidenti a carico del DL in cui descrive dinamica dell’incidente mancato e problematiche della messa in sicurezza;

■ il GRI valuta le condizioni, determina una risoluzione interna all’azienda e invia comunicazione di risoluzione incidente al lavoratore che effettua la segnalazione e al GRTVI, spiegando modalità esecutive e logistiche intervenute nella procedura.